

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE

FPS. Experiência de quem é referência.



Simulado ENAMED

2026.1

29/04/2026

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** – Verifique se, além deste Caderno, você recebeu o **CARTÃO-RESPOSTA**, destinado à transcrição das respostas das questões de múltipla escolha.
- 02** – Confira se este Caderno contém **100 (cem) questões** de múltipla escolha.
- 03** – Verifique se o seu nome está correto no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, avise imediatamente ao Chefe de Sala.
- 04** – As respostas da prova deverão ser transcritas, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**.
- 05** – A prova terá duração de **5 (cinco) horas**. Lembre-se de reservar um período para transcrição das respostas para o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- 06** – Não realize qualquer espécie de consulta ou comunicação com os demais participantes durante o período de prova.
- 07** – Ao terminar a prova, acene para o Chefe de Sala e aguarde-o em sua carteira. Ele recolherá o seu material de prova e coletará a sua assinatura na Lista de Presença.
- 08** – Atenção! Você deverá permanecer na sala de aplicação por, no mínimo, **2(duas) horas** a partir da prova e só poderá levar este Caderno **quando faltarem 30 minutos** para o término da Prova.
- 09** – O **CARTÃO-RESPOSTA** deverá ser entregue ao Chefe de Sala ao término da prova.

NOME:

SALA:

CURSO/PERÍODO:

CPF:

QUESTÃO 1

Menina de 9 anos com diagnóstico de diabetes melito tipo I há cerca de dois anos, com acompanhamento irregular e má adesão à terapêutica com insulina. Apresentou sintomas gripais e febre, iniciado há dois dias, e hoje, passou a apresentar episódios de dor abdominal, vômito, poliúria e polidipsia. Chega ao serviço levemente agitada, porém colaborativa, taquipneica, porém sem alterações na ausculta respiratória. SatO₂ = 98% em ar ambiente. Glicemia capilar: 391 mg/dL.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual o achado esperado na gasometria desta paciente?

- A) Acidose metabólica, ânion GAP elevado, hipocalcemia.
- B) Acidose metabólica sem elevação de ânion gap, hipercalemia.
- C) Acidose respiratória, ânion GAP elevado, hipocalcemia.
- D) Alcalose metabólica, sem elevação de ânion GAP, hipercalemia.

QUESTÃO 2

Menino de 1 ano e 9 meses, hígido, é levado para consulta de puericultura. Genitora encontra-se preocupada, ele não se interessa nem nos familiares, nem em outras crianças. Sempre brinca sozinho e, quando é tentada interação, se interessa mais no brinquedo do que na pessoa com quem está brincando. Além disso, não responde quando chamado pelo nome, nem aponta para objetos indicando o que deseja. Quanto aos marcos do desenvolvimento para a idade, ele empilha três cubos, remove peças de roupa e chuta uma bola, porém não aponta duas figuras em um grupo de 5. Aplicado instrumento M-CHAT, com pontuado 4 (risco moderado para o transtorno do espectro autista).

A partir desse achado, qual a primeira conduta, de acordo com a caderneta da Criança do Ministério da Saúde?

- A) Reaplicar o M-CHAT após aniversário de 2 anos.
- B) Aplicar a entrevista de seguimento para obter informações adicionais sobre as respostas que indicam risco.
- C) Encaminhar para avaliação diagnóstica e intervenção precoce, acionando rede de atenção especializada.
- D) Orientar a mãe sobre a estimulação da criança e marcar retorno com 30 dias.

QUESTÃO 3

Criança de 8 anos, dá entrada em hospital de referência com história de febre e dor nas articulações, iniciados na última semana. "Teve dor de garganta" há aproximadamente 20 dias, sem tratamento. Ao exame, estava afebril. Apresentava dor e edema em articulações de joelhos, tornozelos e punhos. Ausculta cardíaca com sopro holossistólico em foco mitral 3/6+. Realizados exames complementares, que evidenciaram: radiografia com discreto aumento de área cardíaca e sinais de congestão pulmonar. Ecocardiograma com aumento de câmaras cardíacas esquerdas. Títulos elevados de ASLO.

Quais medicações estão indicadas?

- A) Penicilina benzatina e naproxeno.
- B) Penicilina benzatina e prednisona.
- C) Naproxeno e prednisona.
- D) Ibuprofeno e penicilina benzatina.

QUESTÃO 4

Adolescente de 12 anos é levado para unidade de pronto atendimento devido a cefaleia, urina escurecida e edema nos membros inferiores iniciados na última semana. Recentemente, realizou tratamento para impetigo em unidade de atenção primária. Ao exame: Estado geral regular, colaborativo, hipocorado, eupneico. Presença de edema em ambos os membros inferiores. Sinais vitais: frequência cardíaca 98 bpm; Frequência respiratória 20 ipm; SatO₂ 98%; PA: 113x80 mmHg (acima do percentil 90 para a idade, sexo e estatura). Fita reagente de urina evidenciou hemácias +++; traços de proteína e nitrito negativo.

Qual achado laboratorial poderia corroborar com a principal hipótese diagnóstica?

- A) Hipoalbuminemia.
- B) Redução do complemento C3.
- C) Aumento do nível sérico de creatinina.
- D) Aumento da relação proteína/creatinina urinária.

QUESTÃO 5

Observe a notícia a seguir:

"SUS passa a oferecer imunobiológico para proteger bebês e crianças com comorbidades contra a bronquiolite"

O nirsevimabe oferece proteção imediata contra o vírus sincicial respiratório, sem a necessidade de estimular o organismo a produzir anticorpos



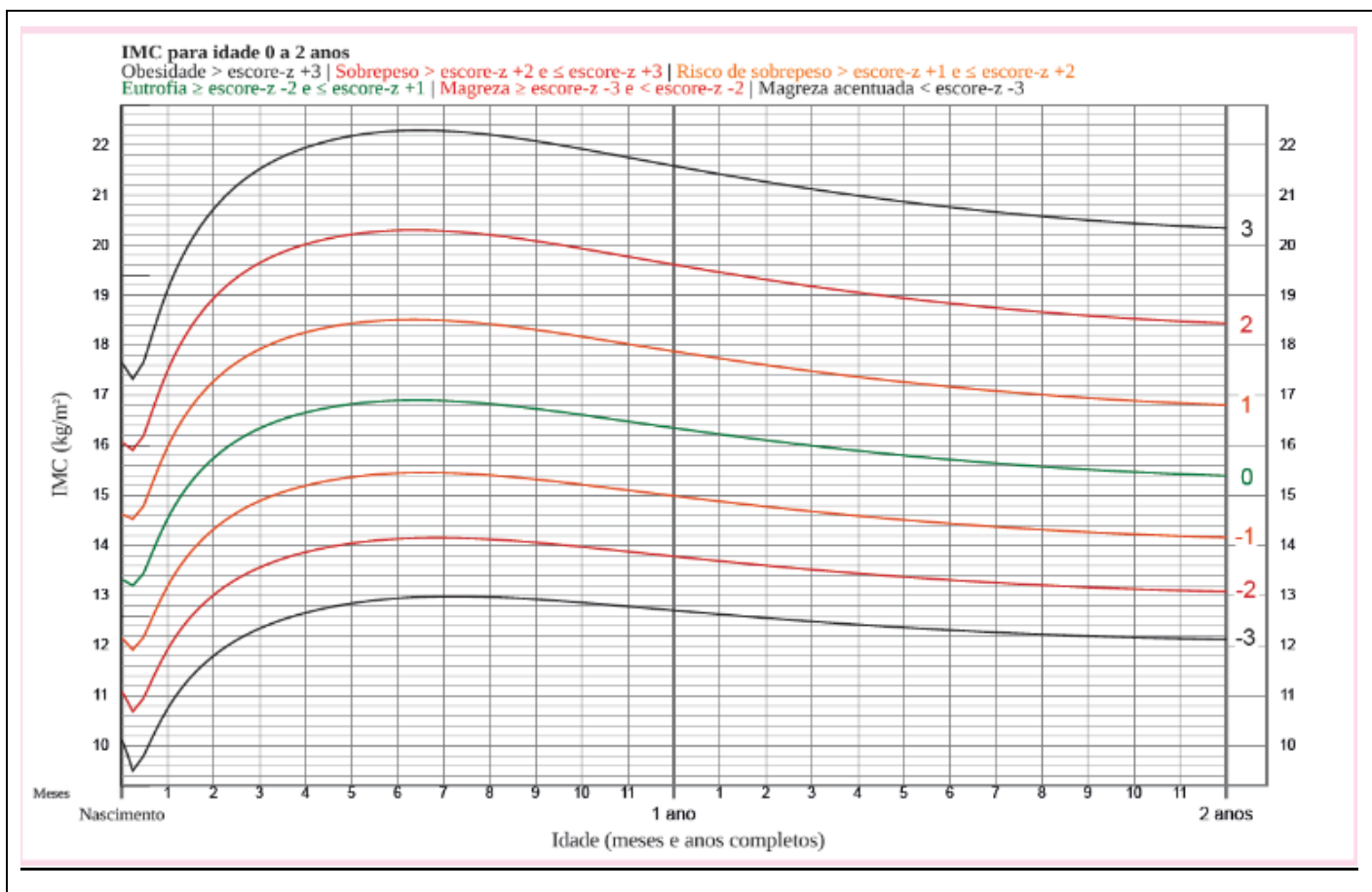
Qual dentre os exemplos a seguir teria indicação de receber esse imunológico pelo SUS, de acordo com o Ministério da Saúde?

- A) Menor com 4 anos de idade e quadro de Síndrome de Down.
- B) Paciente com 6 meses e história de pneumonia aos 3 meses de idade.
- C) Bebê com 15 dias de vida, prematuro com 36 semanas de idade gestacional.
- D) Criança de 1 ano, com comunicação interatrial sem repercussão hemodinâmica.

QUESTÃO 6

Paciente de 6 meses é atendida em consulta de rotina na Unidade de Atenção Primária e é calculado seu IMC: 18,8 kg/m².

Como classificar essa criança, de acordo com o gráfico da caderneta?



- A) Sobrepeso.
- B) Risco de sobrepeso.
- C) Peso normal para a idade.
- D) Pelo elevado para a idade.

QUESTÃO 7

Criança com 37 semanas de idade gestacional, nascida após indicada cesárea de urgência por batimentos cardíofetais ausentes. À extração, o paciente encontrava-se hipotônico e sem respirar. Foi realizado clampeamento imediato do cordão umbilical e o menor foi conduzido à mesa de reanimação. Após medidas iniciais, seguia sem respirar e com frequência cardíaca de 31 bpm.

Qual o próximo passo indicado para essa criança?

- A) Aspiração das vias aéreas superiores.
- B) Ventilação com pressão positiva.
- C) Realizar intubação orotraqueal.
- D) Iniciar massagem cardíaca.

QUESTÃO 8

Lactente de 6 meses é levado à consulta de rotina pela mãe, que relata aumento do volume da bolsa escrotal direita percebido há cerca de 2 meses. Nega dor, irritabilidade, febre ou episódios de vômitos. Ao exame físico, observa-se aumento de volume escrotal à direita, de consistência cística, indolor à palpação, sem sinais flogísticos. Transiluminação escrotal positiva. Não há redução do volume à compressão manual durante o exame.

Com base no quadro clínico, qual é a conduta mais adequada?

- A) Indicar cirurgia imediata.
- B) Solicitar ultrassonografia escrotal.
- C) Acompanhar clinicamente até 1 ano de idade.
- D) Realizar punção aspirativa do conteúdo escrotal.

QUESTÃO 9

Criança de 3 anos é levada ao ambulatório para investigar episódios recorrentes de pneumonia desde o primeiro ano de vida, além de tosse persistente. De antecedentes familiares, é o primeiro filho de ambos os pais, que são saudáveis e consanguíneos. Não realizou teste do pezinho ao nascer. Ao exame, apresentou quadro de tosse durante a consulta, e trazia roncos e estertores difusos à ausculta. A aparência geral era emagrecida, sendo que na curva de peso para idade encontrava-se abaixo do escore Z -3 e, na de estatura para a idade, abaixo do escore Z -2. Realizou iontoforese, com dosagem de cloreto no suor de 72 mEq/L (Valor de referência <30).

Qual o provável diagnóstico?

- A) Fibrose cística.
- B) Asma brônquica.
- C) Doença granulomatosa crônica.
- D) Imunodeficiência comum variada.

QUESTÃO 10

Um lactente de 4 meses é levado à emergência com história de rinorreia e febre baixa há quatro dias, evoluindo com piora progressiva do padrão respiratório, incluindo dificuldade para mamar e episódios de “chiado no peito”. Ao exame físico, encontra-se em regular estado geral, com taquipneia, tiragem inter e subcostal leve e sibilos difusos à ausculta pulmonar, além de tempo expiratório prolongado. Genitor refere que “nunca cansou” antes.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual o mecanismo fisiopatológico relacionado ao quadro?

- A) Incremento da depuração mucociliar nas vias aéreas.
- B) Broncodilatação sustentada com aumento do fluxo aéreo.
- C) Redução acentuada da permeabilidade vascular pulmonar.
- D) Obstrução de vias aéreas inferiores por atividade inflamatória.

QUESTÃO 11

Criança de 8 anos previamente hígida é levada ao atendimento de urgência por dor intensa no joelho direito iniciada há 3 dias, com piora progressiva e dificuldade para deambular, evoluindo também com febre alta (até 39 °C) e prostração. Refere ferimento recente próximo ao joelho acometido enquanto andava de bicicleta. Ao exame físico, apresenta joelho direito em posição antálgica, com aumento de volume, calor e rubor local e importante limitação à mobilização passiva. Demais articulações sem alterações.

Qual o provável agente etiológico envolvido neste quadro?

- A) *Staphylococcus aureus*.
- B) *Streptococcus pyogenes*.
- C) *Pseudomonas aeruginosa*.
- D) *Streptococcus agalactiae*.

QUESTÃO 12

Recém-nascido-nascido termo, com 30 horas de vida, é submetido ao teste do coraçõzinho no alojamento conjunto. A aferição mostra uma saturação de oxigênio (SpO₂) de 87% na mão direita e de 87% em um dos pés.

Considerando a correta interpretação do teste, qual cardiopatia congênita deve estar presente?

- A) Atresia Pulmonar.
- B) Persistência do canal arterial.
- C) Comunicação interventricular.
- D) Defeito total do septo atrioventricular.

QUESTÃO 13

Uma criança de 6 meses é levada à consulta de puericultura na atenção primária. Nasceu a termo, com peso adequado, apresenta bom crescimento e desenvolvimento, e iniciou alimentação complementar adequada para a idade. Não há sinais clínicos de anemia. Durante a consulta, o profissional orienta sobre a profilaxia da anemia ferropriva com sulfato ferroso.

Qual é a orientação mais adequada, de acordo com as últimas recomendações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria?

- A) Iniciar sulfato ferroso na dose de 1 mg/kg/dia até 24 meses, sem interrupções.
- B) Prescrever 10 a 12,5 mg de ferro elementar ao dia, em uso contínuo até 24 meses.
- C) Prescrever 10 a 12,5 mg de ferro elementar ao dia, em dois ciclos de 3 meses, com intervalo de 3 meses entre eles.
- D) Não iniciar suplementação, pois a criança está em alimentação complementar adequada.

QUESTÃO 14

Adolescente de 16 anos procura a Unidade Básica de Saúde para ser atendido só. Durante a consulta, demonstra boa capacidade de compreensão e participa ativamente das decisões sobre sua saúde, sendo sua autonomia respeitada pela equipe. Ao longo do atendimento, compartilha diferentes aspectos de sua vida e pede que as informações não sejam repassadas a outras pessoas. A médica responsável, porém, identifica uma situação relatada pelo jovem em que será necessária a quebra de sigilo.

Qual situação poderia ter sido?

- A) Ele está namorando e gostaria de orientações sobre o uso de preservativo.
- B) Comenta que tem experimentado bebidas alcoólicas em encontros sociais com amigos.
- C) Menciona pensamentos recorrentes de que “a vida não vale a pena” e admite já ter pensado em se machucar.
- D) Relata conflitos familiares frequentes, mas sem relato de violência ou risco à integridade.

QUESTÃO 15

Paciente com 10 dias de vida é levada pela primeira vez para consulta com pediatra. Nasceu com 38 semanas de idade gestacional, parto domiciliar sem intercorrências. A genitora explica que realizou apenas 4 consultas de pré-natal. Nega intercorrências na gestação e parto. Ao exame, a profissional de saúde responsável pelo atendimento percebeu epicanto, prega palmar única, prega nugal redundante e distância aumentada entre hálux e segundo pododáctilo, sem outras alterações.

Diante da principal hipótese diagnóstica, qual conduta deveria ser tomada?

- A) Explicar em linguagem acessível sobre o fenótipo identificado, solicitar cariótipo, ecocardiograma, hemograma e função tireoidiana
- B) Explicar em linguagem acessível sobre o genótipo identificado, resgatar o teste do pezinho e solicitar perfil lipídico
- C) Realizar teste do coraçõzinho e eletrocardiograma, coleta de cariótipo e recomendar que os pais não tenham outros filhos
- D) Realizar radiografia de mãos e punhos, resgatar teste do pezinho, solicitar hemograma e acolher família devido ao mau prognóstico

QUESTÃO 16

Paciente de 1 ano e 4 meses, e comparece ao posto de saúde para atualizar o calendário vacinal. Cartão vacinal atualizado até o momento das vacinas de 1 ano de idade, inclusive para COVID e Influenza.

Que vacinas ele deverá tomar hoje?

- A) Hepatite A, Reforço VIP, Tetraviral, 1º Reforço DTP.
- B) Febre Amarela, Reforço VIP, Hepatite A, 1º Reforço DTP.
- C) Tetraviral, Reforço ACWY, Reforço VOP, Reforço Pneumo 10.
- D) Reforço VIP, Tríplice viral, Reforço Pneumo 10, Reforço ACWY.

QUESTÃO 17

Criança de 4 anos de idade é levada à unidade de pronto atendimento com história de febre alta há 4 dias, associada a dor abdominal contínua e episódios de vômitos nas últimas 12 horas. A responsável relata que a criança está mais irritada e com menor aceitação de líquidos. Residem em área com abastecimento irregular de água, mantendo recipientes para armazenamento domiciliar, e há relato de vizinhos com quadros febris recentes. Ao exame físico, encontra-se prostrada, com dor à palpação abdominal difusa e fígado palpável a 3 cm do rebordo costal direito. Sinais vitais estáveis, sem hipotensão.

Considerando a principal hipótese diagnóstica e a classificação de risco, qual é a conduta imediata mais adequada?

- A) Hidratação oral domiciliar, com retorno em 48 a 72 horas.
- B) Hidratação oral na unidade, coleta de hemograma e liberação após resultado.
- C) Iniciar reposição volêmica com Soro Fisiológico 0,9% e internação hospitalar.
- D) Iniciar hidratação venosa rápida e encaminhar para unidade de terapia intensiva.

QUESTÃO 19

Menina com passado de prematuridade, atualmente com 2 meses de idade cronológica e 1 de idade corrigida, é atendida em consulta ambulatorial. Durante a consulta, a criança teve seus marcos do desenvolvimento avaliados e foi classificada como "alerta para o desenvolvimento", conforme a caderneta da criança do ministério da saúde, uma vez que não atingia um dos marcos esperados para a faixa etária.

Considerando a idade gestacional corrigida, qual marco a criança deveria ter atingido?

- A) Responde ativamente ao contato social.
- B) Segura objetos.
- C) Levanta a cabeça e se apoiar nos antebraços, de bruços.
- D) Emite sons.

QUESTÃO 18

Criança de 18 meses é levada a uma unidade de saúde com história de diarreia aquosa há dois dias. Ao exame, apresenta-se irritada e intranquila, com olhos fundos, mucosas secas e sede intensa, bebendo líquidos rapidamente quando oferecidos. O sinal da prega abdominal desaparece lentamente. Pulsos periféricos estão cheios. Considerando o cartaz de manejo do paciente com diarreia do Ministério da Saúde, como deve ser classificado o estado de hidratação dessa criança?

- A) Sem desidratação.
- B) Desidratado.
- C) Desidratado grave.
- D) Choque hipovolêmico.

Marcos do Desenvolvimento do Nascimento aos 6 Meses

Marcos	Como pesquisar	Idade em meses						
		0	1	2	3	4	5	6
Postura: pernas e braços fletidos, cabeça lateralizada	Deite a criança em superfície plana, de costas, com a barriga para cima; observe se seus braços e pernas ficam flexionados e sua cabeça lateralizada.							
Observa um rosto	Posicione seu rosto a aproximadamente 30 cm acima do rosto da criança. Observe se a criança olha para você, de forma evidente.							
Reage ao som	Fique atrás da criança e bata palmas ou balance um chocalho a cerca de 30 cm de cada orelha da criança e observe se ela reage ao estímulo sonoro com movimentos nos olhos ou mudança da expressão facial.							
Eleva a cabeça	Coloque a criança de bruços (barriga para baixo) e observe se ela levanta a cabeça, descosta o queixo da superfície, sem virar para um dos lados.							
Sorri quando estimulada	Sorria e converse com a criança; não lhe faça cócegas ou toque sua face. Observe se ela responde com um sorriso.							
Abre as mãos	Observe se em alguns momentos a criança abre as mãos espontaneamente.							
Emite sons	Observe se a criança emite algum som, que não seja choro. Caso não seja observado pergunte ao acompanhante se faz em casa.							
Movimenta os membros	Observe se a criança movimenta ativamente os membros superiores e inferiores.							
Responde ativamente ao contato social	Fique à frente do bebê e converse com ele. Observe se ele responde com sorriso e emissão de sons como se estivesse "conversando" com você. Pode pedir que a mãe o faça.							
Segura objetos	Ofereça um objeto tocando no dorso da mão ou dedos da criança. Esta deverá abrir as mãos e segurar o objeto pelo menos por alguns segundos.							
Emite sons, ri alto	Fique à frente da criança e converse com ela. Observe se ela emite sons (gugu, eeee etc.), veja se ela ri emitindo sons (gargalhada).							
Levanta a cabeça e apoia-se nos antebraços, de bruços	Coloque a criança de bruços, numa superfície firme. Chame sua atenção a frente com objetos ou seu rosto e observe se ela levanta a cabeça apoiando-se nos antebraços.							
Busca ativa de objetos	Coloque um objeto ao alcance da criança (sobre a mesa ou na palma de sua mão) chamando sua atenção para ele. Observe se ela tenta alcançá-lo.							
Leva objetos a boca	Ofereça um objeto na mão da criança e observe se ela o leva a boca.							
Localiza o som	Faça um barulho suave (sino, chocalho etc.) próximo à orelha da criança e observe se ela vira a cabeça em direção ao objeto que produziu o som. Repita no lado oposto.							
Muda de posição (rola)	Coloque a criança em superfície plana de barriga para cima. Incentive-a a virar para a posição de bruços.							

QUESTÃO 20

Gestante com 40 semanas de idade gestacional dá entrada na maternidade com em trabalho de parto. Necessitou tratar sífilis gestacional durante o pré-natal, tendo realizado 3 doses semanais de penicilina benzatina, iniciadas 25 dias antes do parto. Evoluiu com parto normal, sem intercorrências. Criança com boas condições de vitalidade e exame físico normal. Qual conduta imediata indicada para o recém-nascido (RN), de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde?

- A) Colher VDRL em amostra oriunda do cordão umbilical.
- B) Parear VDRL sérico do recém-nascido com o da genitora.
- C) Prescrever Penicilina Benzatina intramuscular em dose única.
- D) Realizar radiografia de ossos longos, coleta de LCR e exames séricos.

QUESTÃO 21

Lactente de 6 meses é levado à consulta por episódios recorrentes de contrações abruptas seguidas de componente tônico, com flexão do tronco e do pescoço e movimentos dos membros superiores em adução. Os eventos duram poucos segundos, ocorrem em salvas, principalmente ao despertar. Ao eletroencefalograma, observa-se padrão de ondas lentas de amplitude elevada a muito elevada, associadas a atividade epileptiforme desorganizada, variando em amplitude, duração, morfologia e localização.

Qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Espasmos epilépticos.
- B) Crise de ausência.
- C) Crise tônico-clônica generalizada.
- D) Crise focal motora.

QUESTÃO 22

Adolescente de 14 anos é levado à consulta por queda no rendimento escolar e dificuldade de cumprir tarefas no tempo esperado. Familiares relatam que ele demora excessivamente para finalizar atividades simples, como organizar o material escolar ou tomar banho, pois frequentemente reinicia essas ações. Refere que durante a infância, não possuía dificuldade de concentração ou prejuízos no rendimento escolar. Quando questionado, diz que “sente que não está certo” e que precisa repetir algumas etapas, com receio de que algum ruim aconteça. Embora reconheça que isso o atrapalha, sente-se muito ansioso com a perspectiva de não finalizar essas atividades. Evita comentar sobre esses comportamentos com colegas, pois se sente envergonhado.

Qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Transtorno de ansiedade generalizada (TAG).
- B) Transtorno do espectro autista (TEA).
- C) Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).
- D) Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

QUESTÃO 23

Lactente de 18 meses é levado ao pronto-socorro após episódio de crise convulsiva associada a febre (39°C), iniciada há poucas horas. Segundo o cuidador, apresentou abalos generalizados, com duração aproximada de 3 minutos, seguidos de sonolência por alguns minutos, com recuperação completa. É o primeiro episódio. Ao exame, encontra-se em bom estado geral, ativo, sem déficits neurológicos, com sinais de infecção de vias aéreas superiores.

Qual é a conduta mais adequada neste momento?

- A) Realizar eletroencefalograma.
- B) Solicitar tomografia de crânio.
- C) Investigar a causa da febre.
- D) Iniciar anticonvulsivante.

QUESTÃO 24

Paciente com 6 dias de vida é admitido na urgência com icterícia às custas de bilirrubina indireta, em nível de fototerapia. Não apresentou intercorrências durante o parto e recebeu alta da maternidade assintomático. No momento, a genitora refere dificuldade para amamentar, com pega inadequada e fissura nas mamas. O menor apresentou ainda uma perda de peso superior a 10% do peso do nascimento. Genitora com classificação sanguínea A+ e recém-nascido, O+. Qual é a provável etiologia da icterícia deste paciente?

- A) Icterícia fisiológica.
- B) Icterícia do leite materno.
- C) Icterícia associada ao aleitamento.
- D) Incompatibilidade materno fetal ABO.

QUESTÃO 25

Lactente de 12 meses é levado ao serviço de urgência com história de febre alta (39,5° C) e irritabilidade associada a coriza. Durante o exame físico, a pediatra realiza otoscopia e decide iniciar antibioticoterapia.

Qual achado foi determinante para essa conduta?

- A) Dor à manipulação.
- B) Abaulamento.
- C) Opacidade.
- D) Hiperemia.

QUESTÃO 26

Homem de 27 anos, encaminhado para serviço hospitalar com quadro de dor abdominal em fossa ilíaca direita, com irradiação para flanco direito, há 2 dias. Relata náuseas e vômitos associados. Ao exame físico, taquicárdico, temperatura axilar 39,1°C, com sinais de defesa abdominal em região de fossa ilíaca direita. Traz consigo exames laboratoriais externos:

Exame	Resultado	Valor de Referência
Hemoglobina (g/dL)	12,5	12-16
Hematócrito (%)	39	36-48
Leucócitos totais (cél/mm ³)	14.100	4.000-11.000
Neutrófilos (%)	87	40-80
Proteína C Reativa (mg/L)	42	< 5

Diante do caso descrito, qual a conduta inicial?

- A) Encaminhar ao bloco cirúrgico, para apendicectomia videolaparoscópica.
- B) Solicitar ultrassonografia de abdome total para elucidação diagnóstica.
- C) Solicitar tomografia computadorizada de abdome total de baixa dose.
- D) Tratamento para apendicite complicada, com apendicectomia de intervalo.

QUESTÃO 27

Paciente do sexo masculino, 17 anos, submetido à apendicectomia videolaparoscópica no dia anterior por apendicite aguda. Achados cirúrgicos descreviam apêndice cecal hiperemiado, sem necrose ou perfuração e ausência de líquido livre. No pré-operatório, estava em uso de ceftriaxona e metronidazol. Em sua evolução, apresenta-se sem queixas.

Qual a conduta apropriada para o caso?

- A) Alta hospitalar com antibioticoterapia por 3 dias com ciprofloxacino e metronidazol orais.
- B) Alta hospitalar sem antibioticoterapia, com prescrição de sintomáticos orais.
- C) Manter sob internação para antibioticoterapia, pois ceftriaxona não apresenta formulação oral.
- D) Suspender antibioticoterapia e manter sob internação, com avaliação laboratorial em 48h.

QUESTÃO 28

Mulher, 42 anos, com quadro de dor abdominal em região epigástrica, com irradiação para hipocôndrio direito e região dorsal, associada a náuseas e múltiplos episódios eméticos. Relata início da dor há aproximadamente 36 horas. Ao exame físico, dor abdominal à palpação em hipocôndrio direito, sinal de Murphy positivo. Ultrassonografia com vesícula biliar de paredes espessadas, com cálculos de até 0,5cm em seu interior. Demais estruturas não foram avaliadas por interposição gasosa. Realizado exames laboratoriais:

Exame	Resultado	Valor de Referência
Hemoglobina (g/dL)	11.3	11,5-15.5
Hematócrito (%)	34.6	35-46
Leucócitos totais (cél/mm ³)	12.350	4.000-11.000
Bilirrubina total (mg/dL)	1,6	0,2-1,2
Fosfatase Alcalina (U/L)	122	33-96
Gama-Glutamiltransferase (U/L)	143	7-60
Amilase (U/L)	380	20-96
Lipase (U/L)	633	4-43
Glicose (mg/dL)	122	70-99
LDH (U/L)	136	100-190

Com base nos exames realizados, qual a conduta inicial indicada para essa paciente?

- A) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, por apresentar colangite aguda.
- B) Colectomia videolaparoscópica, mediante quadro de colecistite aguda litíase.
- C) Realização de tomografia computadorizada com contraste, para diagnóstico adequado.
- D) Tratamento clínico para pancreatite aguda, com colecistectomia no mesmo internamento.

QUESTÃO 29

Homem de 78 anos, diabético, acamado por antecedente de AVE isquêmico há 2 anos, em uso de ácido acetilssalicílico e insulina de longa duração, é admitido em serviço hospitalar com familiares por baixa ingesta alimentar e dor referida em região subcostal direita, com piora após alimentação há 2 dias. Após analgesia, houve persistência do quadro, com paciente evoluindo com obnubilação. Há o relato de redução de volume urinário. Traz exames externos do mesmo dia da avaliação, com evidência de leucocitose com desvio à esquerda e elevação de escórias nitrogenadas. Não há diagnóstico prévio de doença renal crônica. Submetido à ultrassonografia de abdome total, com achado abaixo:



Com base nos dados clínicos e exames complementares, qual a conduta?

- A) Antibioticoterapia de largo espectro isolado, por 7 dias.
- B) Colectomia laparoscópica em caráter de emergência.
- C) Colectostomia percutânea guiada por ultrassonografia.
- D) Encaminhamento para nefrologia, por dor secundária à uremia.

QUESTÃO 30

Homem de 48 anos, vítima de atropelamento há 45 minutos, encontrado em via pública desacordado por serviço de atendimento móvel de urgência, encaminhado para serviço hospitalar. Admitido em prancha rígida e colar cervical, intubação orotraqueal na cena, acoplado em ventilação mecânica. Estável hemodinamicamente, não responsivo a estímulos externos, com anisocoria. Restante da avaliação primária sem alterações. Solicitado tomografia de corpo inteiro, com achado de hematoma epidural e ausência de alterações nos demais segmentos avaliados. No retorno para a sala vermelha, paciente apresentou dessaturação. EtCO₂ em 19mmHg, SatO₂ 81% em FiO₂ 80%. Sistema ventilatório acoplado. Realizado E-FAST na sala vermelha, com sinal do código de barras presente à direita e deslizamento pleural à esquerda.

Com base na evolução do paciente, quais a principal hipótese diagnóstica e conduta?

- A) Contusão pulmonar com tórax instável. Encaminhamento para UTI e avaliação da neurocirurgia.
- B) Intubação seletiva após movimentação do paciente. Reposicionamento do tubo orotraqueal.
- C) Pneumotórax simples com repercussão clínica. Drenagem torácica imediata na emergência.
- D) Intubação esofágica accidental. Laringoscopia e nova intubação sob visualização direta.

QUESTÃO 31

Homem de 28 anos, vítima de ferimento por arma branca em região de hipocôndrio direito e parede lateral do abdome há 30 minutos, trazido à emergência por transeuntes. Paciente sonolento, respondendo ao chamado, apresentando frequência cardíaca de 136bpm, pressão arterial de 83x46mmHg. Abdome doloroso à palpação próximo aos ferimentos, sem sinais de peritonite. Realizada punção de dois jectos calibrosos em fossa cubital, com realização de 500mL de solução cristalóide aquecida. Realizado FAST na sala de trauma:



Após reavaliação, paciente com FC 122bpm, PA 91x50mmHg. Realizada sondagem vesical de demora, apresentando hematúria macroscópica.

Qual a próxima conduta a ser realizada?

- A) Laparotomia exploradora.
- B) Tomografia de abdome com triplo contraste.
- C) Exploração digital da ferida.
- D) Videolaparoscopia diagnóstica.

QUESTÃO 32

Mulher de 59 anos, com queixa de dor retroesternal, regurgitação e eructação há 6 meses, com piora no período noturno. Nega perda de peso, náuseas ou vômitos. Relata acompanhamento em serviço de atenção primária, adepta às mudanças de estilo de vida e em uso diário há 3 meses com omeprazol 20mg pela manhã, em jejum. Ao exame físico, pesa 71kg, 1,56m de altura, orofaringe e exame abdominal sem alterações. Endoscopia digestiva alta com achado de esofagite erosiva grau C de Los Angeles.

Com base nos dados clínicos, qual a conduta?

- A) Encaminhamento para cirurgia bariátrica, por indicação de bypass gástrico em Y-de-Roux.
- B) Realização de manometria esofágica de alta resolução para descartar distúrbios de motilidade esofágica.
- C) Indicação de cirurgia para refluxo gastroesofágico, com cardiomiectomia à Heller e funduplicatura à Nissen.
- D) Teste de pepsina salivar para confirmação de DRGE e uso de procinéticos para esvaziamento gástrico à noite.

QUESTÃO 33

Mulher de 65 anos, apresentando dor abdominal em epigástrico e perda de peso não intencional de 15kg em 3 meses. Relata sensação de empachamento após as refeições, mas nega dor abdominal. Nega antecedentes familiares relevantes. Endoscopia digestiva alta com moderada quantidade de resíduo alimentar em câmara gástrica e achado de lesão ulceroinfiltrativa em antro gástrico, submetida a múltiplas biópsias. A lesão permite a passagem do endoscópio até o duodeno.

Histopatológico: Adenocarcinoma gástrico com padrão intestinal.

Submetida à tomografia de tórax, sem evidência de doença oncológica, e de abdome, com achado de linfonodos de artéria gástrica esquerda aumentados de tamanho, sugestivos de acometimento por doença neoplásica.

Qual a conduta inicial para essa paciente?

- A) Terapia nutricional, laparoscopia diagnóstica e encaminhamento para oncologia para quimioterapia perioperatória.
- B) Encaminhamento para cirurgia e realização de gastrectomia subtotal com linfadenectomia à D2
- C) Prescrição de quimioterapia paliativa, mediante a presença de metástases linfonodais.
- D) Realização de gastrojejunostomia à Billroth II para melhor aceitação de dieta por via oral durante o tratamento oncológico.

QUESTÃO 34

Mulher de 55 anos, em 3º dia pós-operatório de esofagectomia em 3 campos (abordagens abdominal, torácica e cervical) por carcinoma escamocelular de esôfago médio, evoluindo com rouquidão e dispneia durante a fala. Não apresenta outros sintomas. Durante a cirurgia, identificados linfonodos aumentados ao longo do nervo vago, com difícil ressecção.

Mediante os dados clínicos e informação referente a cirurgia, qual a justificativa para os sintomas apresentados pela paciente?

- A) Lesão traqueal durante a abordagem cervical.
- B) Secção do nervo vago durante linfadenectomia.
- C) Fístula quilosa por lesão de ducto torácico.
- D) Paralisia de nervo laríngeo recorrente.

QUESTÃO 35

Homem de 72 anos, admitido em serviço hospitalar com quadro de dor abdominal há 5 dias, associada a vômitos de odor fétido e parada de eliminação de fezes e flatos. Nega antecedentes clínicos semelhantes. Refere constipação crônica, com necessidade de uso de laxativos. Nega perda de peso ou hematoquezia. Ao exame físico, frequência cardíaca de 94bpm, abdome distendido, doloroso à palpação, hipertimpânico, sem dor à descompressão brusca. Na admissão, foram solicitados exames laboratoriais, com discreta leucocitose, sem outras alterações, e radiografia de abdome em pé e deitado.



Com base nos achados clínicos e radiológicos, qual a conduta definitiva para o caso?

- A) Tratamento clínico com laxativos orais e lavagem retal.
- B) Internamento em leito de UTI e prescrição de neostigmina.
- C) Laparotomia exploradora para cirurgia de Hartmann.
- D) Colonoscopia descompressiva e passagem de sonda retal.

QUESTÃO 36

Homem de 35 anos, admitido em serviço de urgência com dor lombar com irradiação para região inguinal à direita de forte intensidade, de início súbito e associada a náuseas e vômitos. Refere hematúria macroscópica e nega febre. Tomografia de abdome total sem contraste com evidência de cálculo em junção ureterovesical de 6mm em seu maior eixo. Não há dilatação ureteropielocalicinal ou densificação da gordura perirrenal. Exames laboratoriais sem alteração da função renal.

Qual a conduta para o paciente?

- A) Prescrição de tansulosina por 28 dias e anti-inflamatórios.
- B) Aumento da ingesta hídrica e antiespasmódicos.
- C) Ureterorrenolitotripsia flexível para extração do cálculo.
- D) Litotripsia extracorpórea com ondas de choque.

QUESTÃO 37

Mulher de 68 anos, admitida com quadro de dor abdominal difusa associada a parada de eliminação de fezes e flatos há 3 dias. Nega febre. Sem colonoscopia prévia. Ao exame físico, FC 104bpm, abdome distendido, doloroso à palpação difusa, sem sinais de peritonite.

Exames laboratoriais com elevação discreta de escórias nitrogenadas. Tomografia de abdome total com contraste com achado de lesão em transição retossigmóidea, com distensão de cólon à montante até válvula ileocecal e ausência de fezes ou gás em reto.

Qual a conduta para a paciente?

- A) Retossigmoidectomia.
- B) Colostomia em alça.
- C) Colonoscopia descompressiva.
- D) Colectomia total.

QUESTÃO 38

Homem de 32 anos, em acompanhamento em serviço de atenção primária por quadro de melena intermitente. Nega dor abdominal ou perda de peso. Ao exame, abdome indolor, sem alteração ao exame anorretal, sem massas palpáveis ao toque retal. Antecedente de pai e irmão que faleceram por câncer de cólon aos 45 e 39 anos, respectivamente, após cirurgia de urgência. Solicitado colonoscopia para investigação de melena.

Colonoscopia: Incontáveis pólipos em todo o cólon e reto, sem outras lesões. Realizado biópsias.

Mediante história clínica e antecedentes familiares, qual o diagnóstico mais provável?

- A) Síndrome de Lynch, com mutação de MLH1, MLH2, MSH6 e PMS2.
- B) Síndrome de Cronkhite-Canadá, com mutação do gene MUTYH.
- C) Polipose adenomatosa familiar, com mutação do gene APC.
- D) Síndrome de Lynch, com mutação dos genes STK11 e KRAS.

QUESTÃO 39

Mulher de 38 anos, com lesão melanocítica em parede torácica de 1cm de diâmetro. Relata crescimento progressivo no último ano. Submetida à dermatoscopia, com achado de lesão assimétrica, de bordas irregulares, com coloração heterogênea.

Qual a próxima conduta para o caso?

- A) Biópsia incisional para confirmação diagnóstica.
- B) Biópsia excisional com espessura total e margens mínimas.
- C) Exérese de lesão com margem de 1cm, por apresentar Breslow de 1cm.
- D) Exérese de lesão com margem de 1cm e pesquisa de linfonodo sentinela.

QUESTÃO 40

Homem de 46 anos, previamente hígido, admitido em serviço de emergência com dor em região inguinal direita há 6 horas, associada a abaulamento local e náuseas e vômitos. Refere abaulamento previamente redutível, com dor súbita após esforço físico, sem redução do conteúdo à manipulação, como previamente acontecia. Ao exame físico, FC 96bpm, abdome distendido, doloroso à palpação em hipogástrio, com abaulamento irreductível em região inguinal direita, com hiperemia de parede abdominal.

Qual a próxima conduta para o caso?

- A) Inguinotomia exploradora de emergência.
- B) Tomografia computadorizada de abdome total.
- C) Redução do conteúdo sob sedoanalgesia leve.
- D) Encaminhamento para cirurgia eletiva.

QUESTÃO 41

Homem de 75 anos, encaminhado de serviço de atenção primária após realização de ultrassonografia de abdome para avaliação de hiperplasia prostática benigna, por achado de hérnia inguinal direta à direita. Paciente assintomático, nega abaulamento ou dor em região inguinal.

Qual a melhor conduta para o paciente?

- A) Solicitar exames pré-operatórios, incluindo parecer cardiológico e exames laboratoriais para realização de hernioplastia inguinal direita.
- B) Adotar estratégia de observação (*watchful waiting*), mediante ausência de sintomas e índice de conversão para cirurgia em 1/3 dos casos em 3 anos.
- C) Não valorizar achado do exame de imagem, uma vez que a ultrassonografia é operador dependente, liberando o paciente sem necessidade de seguimento.
- D) Transferência para serviço de cirurgia geral de urgência para avaliação e descartar necessidade de abordagem cirúrgica de urgência.

QUESTÃO 42

Mulher de 31 anos, com queixa de dor anal intensa ao evacuar, associada a presença de sangue em papel higiênico após episódios de evacuação. Refere quadro de início há aproximadamente 4 semanas. Apresenta constipação crônica e nega comorbidades. Ao exame físico, nota-se papila anal hipertrófica e solução de continuidade perianal. Não foi realizado toque retal, por queixa de dor intensa da paciente.

Qual o tratamento adequado para a condição da paciente?

- A) Hemorroidectomia à Milligan-Morgan.
- B) Esfínterectomia lateral interna.
- C) Exérese de papila anal hipertrófica.
- D) Banhos de assento e corticóide tóxico.

QUESTÃO 43

Homem de 30 anos, submetido à hernioplastia inguinal à Lichtenstein há 2 meses, retorna em consulta no ambulatório apresentando hiperemia e dor em topografia de ferida operatória há 3 dias, associada a febre. Ao exame físico, febril ao toque, FC 98bpm e abaulamento em topografia de ferida operatória, com calor e dor locais, sem saída de secreção.

Com base na hipótese diagnóstica principal, qual a conduta?

- A) Antibioticoterapia e exploração em bloco cirúrgico por infecção de sítio cirúrgico.
- B) Compressas mornas e drenagem percutânea de seroma guiada por ultrassonografia.
- C) Internamento hospitalar e desbridamento amplo de ferida por fascíte necrotizante.
- D) Retirada de tela de polipropileno por reação a corpo estranho imunomediada

QUESTÃO 44

Homem de 40 anos, vítima de colisão carro-anteparo fixo em alta velocidade, submetido à laparotomia exploradora para controle de danos há aproximadamente 24 horas. Em vigência de protocolo de transfusão maciça. Em cuidados intensivos, intubado, em ventilação mecânica, com necessidade de suporte com drogas vasoativas.

Quais são as alterações metabólicas mediante o trauma e medidas de suporte que poderão ocorrer?

- A) Hipercalcemia mediada por múltiplas transfusões de concentrados de hemácias, pelo citrato presente.
- B) Hipoglicemia desencadeada por hormônios proinsulínicos, como resposta ao mecanismo de luta e fuga.
- C) Risco aumentado de tromboembolismo venoso, por estado de hipercoagulabilidade causado pelo trauma.
- D) Oligúria funcional por aumento na liberação de catecolaminas e hormônio antidiurético, com retenção hídrica.

QUESTÃO 45

Neonato, com 2 semanas de vida, encaminhado para serviço de cirurgia pediátrica com quadro de vômitos após amamentação e perda de peso após o parto. O aspecto dos vômitos é semelhante ao leite materno e em jato. Ao exame, apresenta-se hipoativo e desidratado, com massa abdominal palpável em epigástrio.

Após os exames laboratoriais, qual o distúrbio hidroeletrólítico que mais comumente é encontrado?

- A) Acidose metabólica hipercalêmica e hiperclorêmica.
- B) Alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica.
- C) Alcalose metabólica hipofosfatêmica e hipercalcêmica.
- D) Acidose mista hipoclorêmica, hipocalcêmica e hipercalêmica.

QUESTÃO 46

Homem de 62 anos, procura o serviço de emergência por quadro de dor abdominal intensa em fossa ilíaca esquerda há 7 dias, com piora nas últimas 24h, associada a constipação e febre. Ao exame físico, sudoreico, temperatura axilar de 38,5°C, frequência cardíaca de 98bpm, PA 118x72mmHg, abdome doloroso à palpação difusa, com defesa em quadrante inferior esquerdo. Exames laboratoriais com leucocitose e desvio a esquerda importantes e elevação de proteína C reativa. realizada tomografia de abdome total com contraste.

Qual a melhor conduta definitiva para o paciente?



- A) Antibioticoterapia com cobertura para gram negativos.
- B) Laparoscopia para toaleta cavitária e colostomia em alça.
- C) Ulcerorrafia gástrica com patch omental de Graham.
- D) Retossigmoidectomia por via convencional.

QUESTÃO 47

Homem de 56 anos, admitido em serviço de emergência por quadro de hematêmese volumosa, com múltiplos episódios eméticos, de início há aproximadamente 2 horas. Relata etilismo social. Ao exame físico, FC 108bpm, PA 98x51mmHg, abdome flácido, indolor à palpação. Após hidratação, solicitado exames laboratoriais, com hemoglobina 7,8, sem disfunção renal. Endoscopia digestiva alta com evidência de lesão ulcerada com sangramento em babação contínuo em antro gástrico, região pré-pilórica.

Mediante achados clínicos e endoscópicos, qual a conduta?

- A) Laparotomia exploradora para antrectomia com vagotomia e piloroplastia.
- B) Inibidor de bomba de prótons em dose de ataque e nova endoscopia em 12 horas.
- C) Ácido tranexâmico, inibidor de bomba de prótons e hemotransfusão com alvo de 9g/dL.
- D) Terapia endoscópica combinada, com adesão de dois métodos hemostáticos.

QUESTÃO 48

Homem de 28 anos, 70kg, resgatado pelo corpo de bombeiros após incêndio em armazém, encontrado desacordado e trazido ao serviço de emergência. Paciente consciente e orientado, em respiração espontânea, com queimaduras em membros superiores em espessura total, sem dor, e queimaduras em tórax com flictenas e dor intensa à manipulação. Apresenta tosse com escarro carbonáceo.

Qual a conduta imediata?

- A) Escarotomia longitudinal de ambos membros superiores.
- B) Encaminhamento para Unidade de Terapia de Queimados.
- C) Intubação orotraqueal assistida por drogas.
- D) Reposição volêmica intensa, com 6.720mL nas próximas 24h.

QUESTÃO 49

Mulher de 37 anos, procura o serviço de emergência por quadro de dor abdominal pós-alimentar intermitente, localizada em hipocôndrio esquerdo, associada a náuseas e vômitos. Em pós-operatório tardio de bypass gástrico em Y-de-Roux, com perda de 30kg em 7 meses, referindo início da dor após perda de peso. Ao exame físico, normocárdica, abdome doloroso à palpação em hipocôndrio esquerdo, sem sinais de peritonite. Solicitados exames laboratoriais.

Exame	Resultado	Valor de Referência
Hemoglobina (g/dL)	10,8	11,5-15,5
Hematócrito (%)	32,7	35-46
Leucócitos totais (cél/mm ³)	14.000	4.000-11.000
Sódio (mEq/L)	127	135-145
Potássio (mEq/L)	3,1	3,5-5,1
Amilase (U/L)	55	20-96
Lipase (U/L)	38	4-43
LDH (U/L)	156	100-190

Tomografia de abdome total com contraste evidencia ingurgitamento do mesentério, com torção dos vasos mesentéricos e espessamento e dilatação com níveis hidroaéreos de alças de delgado localizadas em hipocôndrio esquerdo. Com base nos achados clínicos e radiológicos, qual a conduta para o caso?

- A) Uso de vasodilatadores arteriais, por vasoespasmio mesentérico.
- B) Laparotomia exploradora para ressecção de alças intestinais.
- C) Laparoscopia diagnóstica e correção de hérnia interna.
- D) Reposição de sódio e potássio para tratamento de íleo metabólico.

QUESTÃO 50

Mulher de 59 anos, previamente hígida, admitida em serviço de urgência por quadro de icterícia progressiva e distensão abdominal pós-prandial há 3 semanas. Nega prurido. Relata perda de peso não intencional no mesmo período de aproximadamente 8kg. Ao exame, FC 84bpm, abdome com massa abdominal palpável em hipocôndrio direito, indolor e móvel. Solicitados exames laboratoriais

Exame	Resultado	Valor de Referência
Hemoglobina (g/dL)	12,2	11,5-15,5
Hematócrito (%)	37,6	35-46
Leucócitos totais (cél/mm ³)	8.900	4.000-11.000
Bilirrubina total (mg/dL)	8,8	0,2-1,2
Bilirrubina direta (mg/dL)	7,9	0,1-0,8
Amilase (U/L)	55	20-96
Lipase (U/L)	38	4-43
LDH (U/L)	156	100-190

Tomografia computadorizada de abdome total com contraste com evidência de lesão periampular de 1,1cm em seu maior diâmetro, com dilatação de vias biliares intra e extra-hepáticas à montante. Ausência de comprometimento vascular ao exame.

Qual a conduta adequada para acompanhamento do caso?

- A) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica para tratamento de colangite.
- B) Biópsia percutânea e terapia paliativa por lesão ser irressecável e palpável.
- C) Estadiamento e encaminhamento para avaliar ressecção cirúrgica primária.
- D) Drenagem transparietohepática para tratamento da icterícia.

QUESTÃO 51

Você atende na Unidade Básica de Saúde um homem de 45 anos com queixa de manchas na pele há dois dias, sem prurido. O paciente relata que as lesões apareceram subitamente em tronco, membros superiores e inferiores, algumas dolorosas, acompanhadas de febre (37,9°C) e mal-estar. No exame físico, não há novos déficits neurológicos ou dor em trajetos nervosos. Há lesões de pele eritematosas, disseminadas em tronco e nos quatro membros sem disestesias, além de algumas lesões em região pré-tibial eritematosas, dolorosas, mais palpáveis que visíveis. O prontuário indica que o paciente concluiu o tratamento para Hanseníase Multibacilar (PQT-MB) há 14 meses, com alta por cura.

Qual é a conduta terapêutica inicial mais adequada para este paciente?

- A) Novo ciclo de Poliquimioterapia Multibacilar (PQT-MB)
- B) Naproxeno 550mg de 12/12h por 1 semana
- C) Prednisona na dose de 1 mg/kg/dia
- D) Talidomida 400 mg/dia

QUESTÃO 52

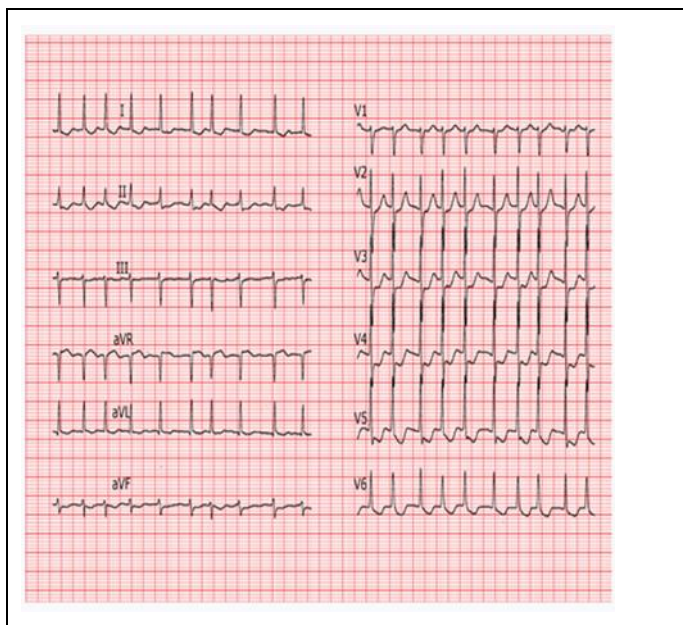
Uma mulher de 24 anos é atendida por você no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A irmã que a acompanha relata que, nas últimas duas semanas, a paciente está extremamente falante, dorme apenas 3 horas por noite sem sentir fadiga e realizou compras excessivas comprometendo a renda da família. Ao exame psíquico, nota-se humor expansivo, pressa para falar, irritabilidade, fuga de ideias e planos grandiosos. A irmã relata que a paciente teve um período de profunda tristeza há dois anos, que durou 4 meses, com incapacidade funcional. Não há evidência de sintomas psicóticos, agressividade e, embora o funcionamento social esteja alterado, a paciente mantém os cuidados pessoais. Você pensa imediatamente em transtorno bipolar, mas precisa diferenciar o tipo.

Qual característica é fundamental para distinguir o diagnóstico de Transtorno Bipolar Tipo II do Tipo I neste caso?

- A) Ocorrência do episódio depressivo maior no histórico.
- B) Intensidade dos sintomas e o grau de prejuízo funcional da paciente.
- C) Duração de 2 semanas dos sintomas de elevação do humor.
- D) Presença de irritabilidade em associação com o humor expansivo.

QUESTÃO 53

Um homem de 62 anos, professor do ensino médio, hipertenso e diabético, procura atendimento ambulatorial para seguimento após episódios mensais de arritmia cardíaca sintomática, o último revertido quimicamente em unidade de emergência há duas semanas. Traz o ECG abaixo e um ecocardiograma transtorácico recente demonstrando átrio esquerdo de 42 mm e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) de 38%, com hipertrofia ventricular esquerda leve. O paciente mantém-se em ritmo sinusal no momento, mas está muito preocupado com a possibilidade de novos episódios de palpitação que prejudicam sua atividade docente.



Qual é a terapia farmacológica antiarrítmica mais indicada para a manutenção do ritmo sinusal em longo prazo?

- A) Amiodarona
- B) Propafenona
- C) Sotalol.
- D) Adenosina.

QUESTÃO 54

Um homem de 72 anos, ex-tabagista (50 maços/ano) e portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), é admitido na emergência com quadro de rebaixamento da consciência, dispneia intensa e tosse produtiva. Após os exames complementares, foi diagnosticado com pneumonia adquirida na comunidade grave. Apesar da antibioticoterapia e suporte ventilatório, o paciente apresentou piora progressiva, evoluindo com insuficiência respiratória aguda e óbito após 48 horas de internação.

No preenchimento da Declaração de Óbito (DO), conforme as normas do Ministério da Saúde para o correto encadeamento das causas de morte (Parte I), qual deve ser a sequência mais correta de preenchimento de cima para baixo?

- A) Linha (a): Insuficiência respiratória aguda; Linha (b): Pneumonia; Linha (c): DPOC.
- B) Linha (a): Parada cardiorrespiratória; Linha (b): Pneumonia; Linha (c): DPOC.
- C) Linha (a): DPOC; Linha (b): Pneumonia; Linha (c): Insuficiência respiratória aguda.
- D) Linha (a): Insuficiência respiratória aguda; Linha (b): Pneumonia; Linha (c): Tabagismo.

QUESTÃO 55

Um homem de 52 anos comparece à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. É tabagista ativo e nega outras comorbidades conhecidas. Ao exame físico, você constata uma pressão arterial (PA) de 144/92 mmHg, confirmada em duas ocasiões distintas. O índice de massa corporal (IMC) é de 28 kg/m². Os exames laboratoriais revelam LDL-colesterol de 165mg/dL, glicemia de jejum de 102 mg/dL e uma taxa de filtração glomerular estimada de 85 mL/min/1,73m². De acordo com os escores de risco recomendados, o paciente foi estratificado como possuindo Risco Cardiovascular Global Médio/Moderado.

Considerando a classificação da pressão arterial e a estratificação de risco cardiovascular deste paciente, qual é a abordagem inicial mais recomendada, de acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2025)?

- A) Monoterapia com Clortalidona.
- B) Combinação de Enalapril e Anlodipino.
- C) Iniciar nebivolol por ser betabloqueador de 3ª geração.
- D) Prescrever mudanças no estilo de vida por 6 meses antes do tratamento farmacológico.

QUESTÃO 56

Um homem de 38 anos, em situação de rua, é admitido no serviço de urgência com quadro de hemoptise de moderado volume. Relata que apresenta tosse produtiva, febre vespertina e perda ponderal não quantificada há cerca de um mês. Ao exame físico, apresenta-se emagrecido, hipocorado (2+/4+) e com estertores crepitantes em ápice de hemitórax direito. A radiografia de tórax é mostrada abaixo. O paciente nega tratamentos anteriores para tuberculose.



Qual é o exame laboratorial prioritário a ser solicitado para este paciente?

- A) Baciloscopia direta do escarro (Pesquisa de BAAR), com coleta de duas amostras.
- B) Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB).
- C) Cultura para micobactéria em meio líquido com teste de sensibilidade.
- D) Teste de liberação de Interferon-gama (IGRA).

QUESTÃO 57

Você atende no ambulatório de clínica médica uma mulher de 42 anos, assintomática e sem antecedentes mórbidos, que traz exames laboratoriais solicitados por outro médico, cujas únicas alterações são duas dosagens de ferritina sérica elevadas (340 µg/L e 410 µg/L, com 4 semanas de intervalo).

Considerando que o índice de saturação de transferrina (IST) é elevado (52%), qual seria o exame mais importante para a sequência de investigação da paciente?

- A) Biópsia hepática
- B) Ressonância cardíaca
- C) Dosagem de ceruloplasmina
- D) Pesquisa de mutações no gene HFE

QUESTÃO 58

Um homem de 64 anos, com histórico de hipertensão arterial de longa data, é acompanhado em ambulatório de nefrologia devido a doença renal crônica (DRC) estágio 4 (Taxa de Filtração Glomerular estimada de 22 mL/min/1,73 m²). O paciente não está em diálise. Em sua consulta de rotina, os exames laboratoriais revelam: cálcio sérico total de 8,8 mg/dL e fósforo sérico de 5,4 mg/dL (valor de referência: 2,5 a 4,5 mg/dL).

De acordo com as evidências atuais para o manejo de pacientes com DRC não dialíticos (estágios 3 a 5), qual é a conduta mais recomendada para o controle da hiperfosfatemia neste caso?

- A) Iniciar precocemente o uso de quelantes de fósforo à base de cálcio para atingir níveis de fósforo abaixo de 4,0 mg/dL.
- B) Priorizar a restrição dietética de fosfatos e considerar o início de quelantes se os níveis de fósforo estiverem persistentemente elevados.
- C) Prescrever quelantes à base de alumínio como terapia de primeira linha para evitar a calcificação vascular.
- D) Iniciar imediatamente o uso de tenapanor em combinação com restrição proteica rigorosa.

QUESTÃO 59

Você realiza o atendimento de uma mulher de 78 anos, levada ao serviço de urgência por familiares devido a quadro de confusão mental e sonolência nas últimas 12 horas. Não há registro de tosse, dispneia, diarreia ou queixas urinárias evidentes. A paciente é portadora de hipertensão e diabetes tipo 2, em uso regular de metformina, dapagliflozina, losartana e anlodipino. Apresenta-se desorientada, com Glasgow de 13. PA= 118/68 mmHg, Frequência Cardíaca= 105 bpm, Frequência Respiratória= 24 irpm, Temperatura axilar= 38,4°C e SpO₂= 93% no ar ambiente. Não tem sinais de irritação peritoneal ou alterações na ausculta cardiopulmonar. O lactato venoso inicial é de 2,2 mmol/L.

Qual é a conduta prioritária a ser instituída para esta paciente na primeira hora de atendimento?

- A) Infusão rápida de 30 mL/kg de cristaloides antes de qualquer medida diagnóstica.
- B) Identificação do foco infeccioso por exames de imagem (TC de crânio e abdome).
- C) Coletar hemoculturas e iniciar antibioticoterapia de amplo espectro.
- D) Punção lombar antes de administrar a primeira dose de antimicrobiano.

QUESTÃO 60

Um homem de 22 anos, com diagnóstico de asma desde a infância, comparece à consulta ambulatorial de clínica médica. Atualmente, utiliza budesonida em dose baixa fixa, uma vez ao dia, e salbutamol apenas quando apresenta sintomas. Relata que nos últimos 30 dias vem apresentando sintomas diurnos três vezes por semana, teve um despertar noturno devido à tosse e necessidade de usar o salbutamol para alívio quase diariamente. Nega limitação em suas atividades físicas habituais.

De acordo com os critérios de avaliação de controle e as recomendações de tratamento da estratégia GINA 2025, qual é a classificação correta do controle da asma deste paciente e a conduta recomendada para o ajuste terapêutico?

- A) Asma bem controlada; manter a dose do CI atual e substituir o salbutamol por formoterol isolado para alívio.
- B) Asma parcialmente controlada; dobrar as doses de budesonida e salbutamol e reforçar a técnica inalatória.
- C) Asma não controlada; associar a budesonida em dose baixa com o formoterol para manutenção e resgate.
- D) Asma em exacerbação; prednisona por 5 dias, manter budesonida e salbutamol como atualmente.

QUESTÃO 61

Um homem de 54 anos, com diagnóstico de cirrose hepática por álcool (Child-Pugh B), foi admitido na unidade de emergência com hematêmese volumosa há 2 horas. Ao exame físico, apresentava-se pálido, com tempo de enchimento capilar de 4 segundos e ascite moderada. Sinais vitais: PA 90/50 mmHg e FC 115 bpm. Os exames laboratoriais da admissão revelaram Hemoglobina de 8,2 g/dL, Plaquetas de 58.000/mm³ e INR de 2,1. O paciente recebeu cristaloides e concentrado de hemácias.

Enquanto aguarda a Endoscopia Digestiva Alta (EDA), qual é a conduta terapêutica inicial mais adequada para o quadro hemorrágico?

- A) Instalar TIPS preemptivo.
- B) Iniciar a terlipressina imediatamente.
- C) Indicar vitamina K em dose de ataque.
- D) Administrar plasma fresco congelado transfusão de plaquetas.

QUESTÃO 62

Um homem de 56 anos, diagnosticado com diabetes há seis anos, vem mantendo o uso de Metformina 850 mg duas vezes ao dia desde o diagnóstico, associado a caminhadas regulares. Ele retorna para consulta de rotina queixando-se de parestesias leves em extremidades e cansaço aos esforços. O exame físico é normal, exceto por uma discreta redução da sensibilidade vibratória em hálux bilateral.

Com base nas recomendações de monitoramento de longo prazo para pacientes em uso de metformina, qual deve ser a conduta prioritária para as queixas deste paciente?

- A) Solicitar dosagem de vitamina B12.
- B) Suspender a metformina imediatamente.
- C) Solicitar eletroneuromiografia de membros inferiores.
- D) Iniciar suplementação empírica de ácido fólico.

QUESTÃO 63

Uma mulher de 68 anos, com diagnóstico de AVC isquêmico agudo em território de artéria cerebral média direita, iniciou infusão de alteplase intravenosa 3 horas após o início dos sintomas (NIHSS inicial = 12). A tomografia (TC) de crânio inicial não apresentava sinais de hemorragia. Aos 40 minutos de infusão do trombolítico, a paciente apresenta cefaleia súbita intensa, náuseas e piora do déficit motor, com o NIHSS progredindo para 17.

Diante do quadro, qual é a sequência de condutas imediatas recomendada?

- A) Concluir a infusão de alteplase em uma hora e solicitar uma TC de crânio de controle em 24 horas.
- B) Interromper a alteplase, realizar TC de crânio de urgência e, se houver hemorragia, iniciar a reversão da trombólise.
- C) Administrar imediatamente ácido acetilsalicílico (AAS) e clopidogrel e solicitar TC de crânio.
- D) Trocar a alteplase por tenecteplase e solicitar ressonância magnética de crânio de urgência.

QUESTÃO 64

Uma mulher de 32 anos, com diagnóstico recente de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) com atividade hematológica e articular, iniciará tratamento com Prednisona na dose de 40 mg/dia (dose imunossupressora), com previsão de manutenção por pelo menos 4 semanas. A paciente discute com você a necessidade de atualização do calendário vacinal antes e durante o período de imunossupressão.

Qual das seguintes vacinas pode ser administrada com segurança na paciente acima, conforme as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)?

- A) Vacina recombinante contra o Herpes Zoster.
- B) Vacina contra a Febre Amarela.
- C) Vacina Tríplice Viral.
- D) Vacina contra o rotavírus.

QUESTÃO 65

Uma mulher de 68 anos, portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) grave, é admitida na Unidade de Terapia Intensiva com quadro de insuficiência respiratória aguda e choque séptico de foco abdominal. Ao exame físico, apresenta-se torporosa, com perfusão periférica lentificada e uso de musculatura acessória. A gasometria arterial e os eletrólitos séricos colhidos na admissão revelam os seguintes valores:

VARIÁVEIS/ RESULTADOS
pH: 7,12
pO ₂ : 53 mmHg
HCO ₃ ⁻ : 19 mmol/L
pCO ₂ : 60 mmHg
Sódio (Na ⁺): 140 mmol/L
Cloro (Cl ⁻): 102 mmol/L
Albumina: 4,0 g/dL

De acordo com o método de Henderson-Hasselbalch, qual é o diagnóstico acidobásico completo desta paciente?

- A) Acidose respiratória aguda compensada.
- B) Acidose respiratória crônica e acidose metabólica hiperclorêmica.
- C) Acidose metabólica com ânion gap elevado e acidose respiratória.
- D) Dist. tríplice: acidose metabólica c/ ânion gap elevado, hiperclorêmica e respiratória.

QUESTÃO 66

Uma mulher de 54 anos foi trazida ao pronto-socorro com queixa de dispneia súbita e dor torácica pleurítica à direita há 2 horas. Ela foi submetida a uma artroplastasia total de joelho há 10 dias. Ao exame físico, apresenta-se ansiosa, com frequência respiratória de 28 irpm e saturação de oxigênio de 88% em ar ambiente. Sua pressão arterial é de 82/50 mmHg, com frequência cardíaca de 125 bpm. A avaliação inicial mostra estase jugular, ritmo cardíaco regular com bulhas normofonéticas e ausculta respiratória limpa. Não há evidências de sangramento ativo ou histórico de cirurgias recentes. Foi solicitada uma tomografia de tórax, mostrada abaixo:



De acordo com os critérios de estratificação de risco, qual é a conduta inicial imediata mais adequada para esta paciente?

- A) Início de anticoagulação com heparina de baixo peso molecular.
- B) Realização de trombólise sistêmica com alteplase (100 mg).
- C) Encaminhamento para embolectomia cirúrgica de urgência.
- D) Inserção de filtro de veia cava inferior.

QUESTÃO 67

Você evolui na enfermaria um homem de 67 anos internado para tratamento de pielonefrite aguda. Na admissão, apresentava-se febril (38,8 °C), taquicárdico (112 bpm) e hipotenso (85/55 mmHg), respondendo adequadamente à reposição volêmica inicial. Foi iniciado tratamento empírico com Piperacilina/Tazobactam e Vancomicina. Após 48 horas, o paciente está afebril e hemodinamicamente estável. O laboratório de microbiologia comunica que as hemoculturas da admissão (2/2 pares) apresentam crescimento de bacilos gram-negativos. O foco infeccioso urinário foi confirmado por imagem e urocultura. O paciente não é imunossuprimido e não possui dispositivos invasivos além do cateter periférico para medicação.

Considerando a estabilidade clínica do paciente e as evidências atuais sobre o tratamento de bacteremia por Enterobacterales, qual é a conduta mais adequada neste momento?

- A) Manter o esquema de Piperacilina/Tazobactam e Vancomicina por 14 dias para garantir a esterilização da corrente sanguínea.
- B) Suspender a Vancomicina e considerar o ajuste do tratamento após o resultado da espécie bacteriana e do antibiograma.
- C) Trocar imediatamente o tratamento para Cefepima devido ao risco de produção de AmpC ou ESBL pelo Bacilo Gram-negativo.
- D) Manter o esquema atual até completar 7 dias e, caso as hemoculturas de controle sejam negativas, suspender os antibióticos.

QUESTÃO 68

Um homem de 72 anos, hipertenso e ex-tabagista, procura atendimento ambulatorial com queixa de cansaço progressivo aos esforços e necessidade de usar três travesseiros para conseguir dormir há três semanas. Ao exame físico, apresenta frequência cardíaca de 106 bpm, pressão arterial de 150/90 mmHg e saturação periférica de oxigênio de 94% no ar ambiente. À ausculta, observa-se a presença de uma terceira bulha (B3) e estertores finos nas bases pulmonares. Há edema de membros inferiores (2+/4+).

Qual dos sinais descritos no paciente possui a maior especificidade para o diagnóstico de IC?

- A) Edema de membros inferiores.
- B) Presença de terceira bulha (B3).
- C) Estertores crepitantes pulmonares.
- D) Presença de taquicardia em repouso.

QUESTÃO 69

Uma mulher de 24 anos com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico (LES) há 2 anos, apresenta-se na urgência edema de membros inferiores e urina espumosa. Até então, só tinha manifestações cutâneas e articulares. Exames laboratoriais revelaram creatinina de 2,1 mg/dL (valor basal era de 0,8 mg/dL há três meses), albumina sérica de 2,6 g/dL e exame de urina tipo 1 mostrando hematúria dismórfica e proteinúria de 3,5 g/dia. Foi internada para realização de biópsia renal, que revelou glomerulonefrite proliferativa difusa (Classe IV-G) com índice de atividade elevado e presença de crescentes em 25% dos glomérulos.

Qual é a terapia de indução inicial mais adequada para esta paciente, de acordo com as recomendações atuais?

- A) Prednisona em altas doses associada a Azatioprina.
- B) Ciclofosfamida endovenosa associada a pulsoterapia com Metilprednisolona.
- C) Micofenolato de mofetila isolado em baixas doses.
- D) Ciclosporina associada a Rituximabe.

QUESTÃO 70

Um homem de 58 anos, tabagista e hipertenso em uso de anlodipino, comparece à consulta de rotina sem queixas clínicas. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, corado e com sinais vitais estáveis. Traz consigo resultado de hemograma coletado em exame admissional, que revela os seguintes valores: Hemoglobina: 10,0 g/dL; Hematócrito: 30%; Volume Corpuscular Médio (VCM): 89 fL; Reticulócitos: 1,5%; Leucócitos: 5.800/mm³ (contagem diferencial normal); Plaquetas: 298.000/mm³.

Qual é o próximo passo mais adequado na investigação diagnóstica deste paciente?

- A) Endoscopia digestiva alta e colonoscopia.
- B) Dosagem de ferritina, saturação de transferrina e creatinina.
- C) Dosagem de haptoglobina, desidrogenase láctica (DHL) e bilirrubinas.
- D) Realização de teste da antiglobulina direta (Coombs direto).

QUESTÃO 71

Uma mulher de 55 anos, assintomática, é atendida por você na Unidade Básica de Saúde (UBS) em consulta de rotina. Ela é ex-tabagista (parou há 5 anos, com carga tabágica de 10 maços-anos) e não possui antecedentes pessoais ou familiares de neoplasias. Durante a consulta, ela questiona o médico sobre a necessidade de realizar exames para "check-up", expressando preocupação específica com a possibilidade de câncer.

Considerando as recomendações atuais de rastreamento para pacientes assintomáticos e sem fatores de risco genéticos, qual orientação você deve fornecer a esta paciente?

- A) Colonoscopia para rastreio de câncer colorretal.
- B) Ultrassonografia de tireoide para rastreio de nódulos.
- C) Tomografia de tórax de baixa dose para rastreio de câncer de pulmão.
- D) Ultrassonografia transvaginal para rastreio de câncer de endométrio.

QUESTÃO 72

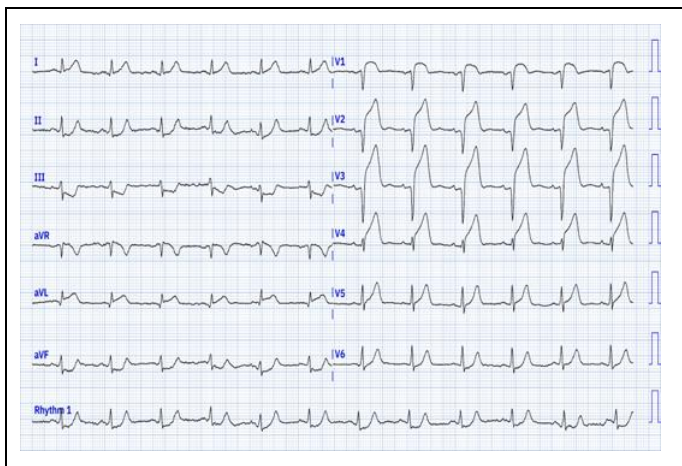
Um homem de 29 anos, que se identifica como homem que faz sexo com homens (HSH), procura seu atendimento na Unidade Básica de Saúde interessado em iniciar a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) para o HIV. Ele relata parcerias sexuais casuais e uso inconsistente de preservativos. Nega comorbidades, uso de medicações contínuas ou sintomas de infecção aguda. Você solicitou um teste rápido para HIV, que resultou não reagente.

Além da confirmação da soronegatividade para o HIV, qual é o cuidado laboratorial essencial que deve preceder a prescrição do esquema padrão de PrEP (Tenofovir + Emtricitabina), de acordo com o protocolo do SUS?

- A) Avaliação da função renal por meio da creatinina sérica.
- B) Dosagem de transaminases (ALT/AST) para avaliar hepatotoxicidade.
- C) Realização de carga viral para HIV por técnica de PCR.
- D) Dosagem de CPK (creatina fosfoquinase) para monitorar miopatia.

QUESTÃO 73

Você está no plantão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e atende um homem de 55 anos com dor retroesternal em aperto de forte intensidade há 90 minutos, irradiada para o ombro esquerdo, associada a náuseas e sudorese. Foi realizado o seguinte eletrocardiograma na admissão:



A UPA não possui serviço de hemodinâmica, e o hospital de referência com capacidade para intervenção coronariana percutânea (ICP) está localizado a 30 minutos de distância.

Considerando o diagnóstico e a logística para reperfusão, qual é a conduta medicamentosa imediata e a estratégia de transferência mais adequada para este paciente?

- A) Administrar dose de ataque de AAS e clopidogrel, iniciar anticoagulação e providenciar transferência imediata para ICP primária.
- B) Administrar AAS e aguardar a chegada ao serviço de hemodinâmica para iniciar o segundo antiagregante plaquetário e a anticoagulação.
- C) Realizar trombólise química na UPA imediatamente e encaminhar para o hospital de referência para ICP.
- D) Administrar AAS (mastigado), manter o paciente na UPA até o resultado da troponina e, se positiva, transferir para cineangiocoronariografia em até 24 horas.

QUESTÃO 74

Um homem de 62 anos, tabagista ativo e com diagnóstico recente de carcinoma de células escamosas de pulmão, foi trazido à emergência por familiares devido a quadro de letargia progressiva, confusão mental e constipação intestinal. Ao exame físico, apresentava-se desidratado e sonolento. Uma cintilografia óssea realizada na semana anterior foi negativa para lesões blásticas ou líticas. Os exames laboratoriais da admissão revelam: cálcio total: 14,2 mg/dL (Referência: 8,5 a 10,5 mg/dL); fósforo sérico: 2,2 mg/dL (Referência: 2,5 a 4,5 mg/dL); paratormônio (PTH) intacto: 4 pg/mL (Referência: 10 a 65 pg/mL); creatinina: 1,8 mg/dL.

Qual é o mecanismo fisiopatológico mais provável da hipercalcemia neste paciente?

- A) Secreção sistêmica de proteína relacionada ao paratormônio.
- B) Reabsorção óssea direta causada por hipoparatiroidismo.
- C) Aumento da absorção intestinal de cálcio mediada por calcitriol.
- D) Hiperparatiroidismo primário coexistente com a neoplasia.

QUESTÃO 75

Uma mulher de 68 anos comparece à consulta de rotina na Unidade Básica de Saúde. Ela é hipertensa controlada com enalapril e nega sintomas como fadiga, ganho de peso ou intolerância ao frio. Traz exames laboratoriais realizados há duas semanas que mostram: TSH: 7,2 mU/L (Referência: 0,45 a 4,5 mU/L); T4 livre: 1,1 ng/dL (Referência: 0,9 a 1,7 ng/dL); Colesterol Total: 210 mg/dL.

Qual é a conduta inicial mais adequada para esta paciente neste momento?

- A) Iniciar reposição com levotiroxina 25 mcg/dia.
- B) Solicitar dosagem de anticorpos anti-peroxidase tireoidiana (anti-TPO).
- C) Repetir a dosagem de TSH e T4 livre em três meses.
- D) Solicitar ultrassonografia de tireoide para avaliar bócio.

QUESTÃO 76

Uma mulher de 28 anos, primigesta, com 5 semanas de gestação confirmada, comparece à consulta de pré-natal relatando uso contínuo de escitalopram 20 mg/dia para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada, com bom controle dos sintomas. Demonstra preocupação com possíveis riscos ao embrião e questiona se deve suspender a medicação.

Com base nas melhores evidências atuais sobre uso de psicofármacos na gestação, qual a orientação mais adequada?

- A) Suspender imediatamente o escitalopram devido ao alto risco teratogênico no primeiro trimestre e encaminhar para psicoterapia.
- B) Manter o escitalopram na dose atual, considerando que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina apresentam baixo risco teratogênico.
- C) Substituir o escitalopram por benzodiazepínico, que apresenta melhor perfil de segurança no primeiro trimestre da gestação.
- D) Reduzir gradualmente a dose até suspensão completa e encaminhar ao psiquiatra para revisão terapêutica.

QUESTÃO 77

Uma mulher de 35 anos, GII/IA0, com 14 semanas de gestação confirmada por DUM e USG, comparece à consulta de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde. Apresenta cartão da gestação anterior, ocorrida há 11 anos, no qual consta registro de esquema vacinal completo contra tétano, com duas doses de vacina dupla adulto (dT) e uma dose de vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa), realizadas durante o pré-natal anterior. Não recebeu doses adicionais desde então.

Com base nas recomendações atuais sobre imunização na gestação, qual é a conduta mais adequada em relação à profilaxia antitetânica na gestação atual?

- A) Iniciar novo esquema completo com três doses de vacina antitetânica durante a gestação atual.
- B) Não administrar nenhuma dose, pois possui o esquema vacinal completo anterior.
- C) Administrar uma dose de dTpa a partir da 20ª semana da gestação atual.
- D) Administrar uma dose de reforço da vacina dupla adulto (dT).

QUESTÃO 78

Uma adolescente de 14 anos, primigesta, na 39ª semana de gestação, é admitida em maternidade de alta complexidade, encaminhada da atenção básica. Encontra-se em trabalho de parto ativo, com 6 cm de dilatação cervical, contrações regulares e boa vitalidade fetal. Informa que está há cerca de 10 horas sem se alimentar, pois foi orientada no serviço de origem a permanecer em jejum devido ao risco de necessidade de cesariana. Queixa-se de muita fome e cansaço.

Qual é a conduta mais adequada em relação à alimentação dessa parturiente?

- A) Manter jejum absoluto
- B) Liberar dieta completa irrestrita
- C) Permitir apenas ingestão de líquidos claros
- D) Permitir ingestão de líquidos claros e alimentos leves

QUESTÃO 79

Múltipara (G4/P3/A0; 3 partos vaginais) de 34 anos, obesa grau 3 e hipertensa crônica em uso de Metildopa (2g/dia), evolui com parto vaginal a termo em maternidade de referência. Após o nascimento, foi realizada administração de 10 UI de ocitocina intramuscular no terceiro período do parto, associada à dequitação ativa sem intercorrências.

Cerca de 30 minutos após o parto, a paciente apresenta sangramento vaginal abundante, com sinais de instabilidade hemodinâmica. Ao exame, o útero encontra-se flácido e aumentado. A equipe inicia imediatamente massagem uterina bimanual, com resposta parcial e transitória.

Considerando as recomendações mais atuais, qual o próximo passo terapêutico mais adequado?

- A) Iniciar infusão intravenosa de ocitocina em dose terapêutica, associando outros uterotônicos conforme resposta e mantendo suporte hemodinâmico.
- B) Realizar revisão imediata da cavidade uterina para exclusão de restos placentários, associada a antibioticoprofilaxia e suporte volêmico.
- C) Administrar ácido tranexâmico associado a reposição volêmica, seguido de revisão da cavidade uterina.
- D) Indicar histerectomia de urgência, associada à reposição volêmica, antibioticoprofilaxia e estabilização clínica.

QUESTÃO 80

Uma mulher de 28 anos, primigesta, obesa e portadora de hipertensão arterial crônica não controlada, realizou pré-natal irregular na atenção básica. Na 28ª semana de gestação, apresentou episódio de cefaleia intensa, associada a escotomas e edema. Procurou unidade básica de saúde, onde foi medicada com sintomáticos e liberada para casa.

Dois dias depois, evoluiu com crise convulsiva em domicílio, sendo levada por familiares à UPA do bairro, onde houve demora no atendimento inicial e indisponibilidade de sulfato de magnésio. Após transferência tardia para serviço de alta complexidade, já em estado grave, evoluiu com novas convulsões, instabilidade hemodinâmica e óbito.

Como deve ser classificado o caso descrito?

- A) O caso configura near miss materno, pois houve complicações graves relacionadas à gestação, independentemente do desfecho final.
- B) Trata-se de morte materna direta, com presença dos três atrasos: atraso na busca por atendimento, atraso no acesso ao serviço adequado e atraso na qualidade do cuidado prestado.
- C) Trata-se de morte materna indireta, associada a condição clínica pré-existente agravada pela gestação, sem relação com falhas assistenciais.
- D) Trata-se de morte materna evitável, atribuída à gravidade clínica da eclampsia, complicada pelas comorbidades, sem caracterização dos três atrasos.

QUESTÃO 81

Uma mulher de 23 anos, primigesta, encontra-se no 5º dia pós-parto vaginal sem intercorrências de seu primeiro filho. Procura atendimento relatando dor intensa durante a amamentação e dificuldade para manter as mamadas. Ao exame físico, observa-se turgência mamária bilateral e presença de fissuras nos mamilos, sem sinais de abscesso ou infecção. O recém-nascido apresenta sucção frequente, porém com pega aparentemente inadequada.

Com base nas recomendações atuais, qual é a conduta terapêutica mais adequada?

- A) Manter a amamentação, iniciar antibiótico profilático e realizar ordenha manual, oferecendo o leite em seringa ao recém-nascido até cicatrização das fissuras.
- B) Manter a amamentação, corrigir a técnica de pega, orientar ordenha para alívio da turgência e aplicar leite materno nas fissuras mamilares.
- C) Interromper a amamentação bilateralmente, iniciar fórmula infantil e prescrever pomadas cicatrizantes tópicas até cicatrização das fissuras.
- D) Prescrever anti-inflamatórios, realizar ordenha manual e suspender a amamentação até resolução completa do quadro.

QUESTÃO 82

Uma jovem de 21 anos, encontra-se no 18º dia pós-cesárea de seu primeiro filho e procura a Unidade Básica de Saúde acompanhada da mãe. Apresenta-se muito chorosa, referindo cansaço intenso, insônia, perda de apetite, sentimento de incapacidade para cuidar do bebê e falta de prazer nas atividades diárias. Relata que os sintomas iniciaram na primeira semana após o parto, mas têm piorado progressivamente, dificultando o vínculo com o recém-nascido. Nega ideação suicida no momento, porém refere pensamentos frequentes de culpa e inadequação, tem medo de “não ser uma boa mãe”. Nega uso de medicamentos. Ao exame, encontra-se lúcida e orientada, com humor deprimido e fala discretamente lentificada. Ferida operatória de cesárea bem cicatrizada. Demais parâmetros sem anormalidades.

Considerando os principais diagnósticos diferenciais, qual é a conduta mais adequada?

- A) Tranquilizar a paciente e orientar que se trata de blues puerperal, condição autolimitada, sem necessidade de intervenção específica.
- B) Diagnosticar blues puerperal e prescrever benzodiazepínico, mantendo acompanhamento de eventual piora dos sintomas.
- C) Suspeitar de depressão pós-parto, oferecer acolhimento, avaliar risco e encaminhar para acompanhamento em saúde mental.
- D) Diagnosticar depressão pós-parto grave e encaminhar para urgência psiquiátrica.

QUESTÃO 83

Gestante de 25 anos, G2P1A0, com antecedente de parto prematuro na 33ª semana após amniorrexe espontânea, encontra-se atualmente com 32 semanas de gestação, em acompanhamento pré-natal regular, sem intercorrências. Relata boa evolução clínica e não apresenta queixas. Ultrassonografias prévias não evidenciaram encurtamento cervical significativo.

Considerando a prevenção de recorrência de parto prematuro, qual é a conduta mais adequada neste momento gestacional?

- A) Iniciar progesterona vaginal imediatamente, mantendo até a 37ª semana de gestação.
- B) Manter acompanhamento clínico e vigilância obstétrica.
- C) Indicar cerclagem tardia associada ao uso de tocolíticos profiláticos até o termo.
- D) Prescrever antibióticos profiláticos associados à restrição de atividades físicas.

QUESTÃO 84

Uma mulher de 37 anos, primigesta, comparece à segunda consulta de pré-natal com 12 semanas de gestação. Apresenta exame de rotina com glicemia de jejum de 94 mg/dL. Nega história prévia de diabetes e encontra-se assintomática. Demais exames sem alterações.

Qual é a conduta mais adequada?

- A) Considerar o exame normal e repetir o rastreamento entre 24–28 semanas com teste oral de tolerância à glicose.
- B) Solicitar hemoglobina glicada para confirmação diagnóstica
- C) Diagnosticar diabetes mellitus prévio e iniciar metformina imediatamente.
- D) Diagnosticar diabetes gestacional e iniciar orientações dietéticas e acompanhamento glicêmico.

QUESTÃO 85

Uma gestante de 35 anos, primigesta, com índice de massa corporal (IMC) de 28,5 kg/m², comparece à sua segunda consulta de pré-natal na 14ª semana de gestação confirmada por DUM e USG corrigida. Ela não possui diagnóstico prévio de patologias e não utiliza medicamentos. Traz exames laboratoriais solicitados na primeira consulta que evidenciam glicemia de jejum de 136mg/dL e Hemoglobina Glicada (HbA1c) de 6,5%.

Diante do quadro clínico e laboratorial apresentado, qual é a conduta terapêutica imediata mais adequada para este caso?

- A) Diagnosticar Diabetes Mellitus Gestacional e iniciar terapia nutricional associada à atividade física, com reavaliação do perfil glicêmico em duas semanas.
- B) Diagnosticar Diabetes Mellitus Pré-gestacional e instituir imediatamente mudanças no estilo de vida associadas à insulino terapia, visando controle rigoroso.
- C) Diagnosticar Diabetes Mellitus Pré-gestacional e prescrever Metformina 500 mg duas vezes ao dia, por ser a droga de primeira escolha para pacientes obesas.
- D) Solicitar teste de tolerância oral à glicose (TOTG 75g) para confirmar o diagnóstico de diabetes antes de iniciar qualquer intervenção farmacológica.

QUESTÃO 86

Uma mulher de 41 anos, G2P1A0, com IMC de 32kg/m², comparece à consulta de pré-natal na 12ª semana de gestação. Seu parto anterior ocorreu há 6 anos, por via vaginal, sem qualquer intercorrência obstétrica. A paciente é normotensa, não possui comorbidades e não utiliza medicamentos. Durante a anamnese, ela questiona sobre a necessidade de utilizar Ácido Acetilsalicílico (AAS) para prevenir a "pressão alta na gravidez", pois leu sobre o assunto.

Com base nas diretrizes mais atuais, qual a orientação correta para este caso?

- A) Não há necessidade de profilaxia para essa paciente.
- B) Indicar o uso de AAS 100 mg/dia a partir deste momento.
- C) Indicar o uso de AAS após a 20ª semana de gestação.
- D) Indicar o uso de AAS associado ao Carbonato de Cálcio 1,5 a 2,0g/dia.

QUESTÃO 87

Uma gestante de 21 anos, primigesta (G1P0A0), com 35,5 semanas de gestação é admitida na emergência obstétrica com queixa de cefaleia frontal persistente e "visão embaçada" há mais ou menos 6 horas. Ao exame físico, apresenta-se consciente, orientada, com pressão arterial de 170/120 mmHg e 160/110 mmHg após repouso em decúbito lateral esquerdo. Ao exame obstétrico, os batimentos cardíofetais são de 144bpm com boa variabilidade. O toque vaginal revela: colo centralizado, com 3 cm de dilatação, 40% de apagamento, apresentação cefálica no plano 0 de De Lee, bolsa íntegra. Os exames laboratoriais revelam creatinina de 1,3 mg/dL e plaquetas de 85.000.

Diante do diagnóstico, qual a conduta imediata mais adequada?

- A) Iniciar Sulfato de Magnésio, realizar controle pressórico agudo e proceder com a indução do parto após estabilização materna, visto o cenário favorável.
- B) Realizar a estabilização pressórica com Hidralazina IV e iniciar Sulfato de Magnésio (esquema Pritchard ou Zuspan), seguido de interrupção da gestação por via alta.
- C) Iniciar Sulfato de Magnésio, administrar Betametasona para aceleração da maturidade pulmonar fetal e aguardar 48 horas para a interrupção da gestação.
- D) Iniciar Sulfato de Magnésio e prescrever furosemida para redução dos níveis pressóricos e prevenção de edema agudo de pulmão.

QUESTÃO 88

Gestante de 19 anos, primigesta (G1P0A0), com 29 semanas de idade gestacional, comparece à consulta pré-natal de rotina na Unidade Básica de Saúde apresentando resultado de VDRL reagente com titulação de 1:8 realizado há 8 dias. O Teste Rápido (TR) realizado na primeira consulta (8 semanas) e o VDRL do primeiro trimestre foram ambos não reagentes. A paciente é assintomática e o exame físico é normal. Ela refere parceiro sexual fixo nos últimos 12 meses, que é assintomático e não possui histórico de tratamento para infecções sexualmente transmissíveis.

De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil, qual a conduta mais adequada para garantir o tratamento materno e a prevenção da sífilis congênita?

- A) Iniciar Penicilina G Benzatina 2,4 milhões UI (dose única) para a gestante; para o parceiro, realizar teste rápido e tratá-lo com 2,4 milhões UI (dose única) se o teste for reagente.
- B) Iniciar Penicilina G Benzatina 2,4 milhões UI (3 doses semanais) para a gestante; o parceiro deve ser tratado imediatamente com 2,4 milhões UI (dose única).
- C) Iniciar Penicilina G Benzatina 2,4 milhões UI (total de 3 doses semanais) para a gestante; para o parceiro, solicitar VDRL e aguardar o resultado para definir o esquema terapêutico.
- D) Solicitar teste treponêmico (como FTA-Abs ou Teste Rápido) para a gestante e aguardar a confirmação diagnóstica; o parceiro deve ser tratado somente após a confirmação materna.

QUESTÃO 89

Uma adolescente de 15 anos, menarca há 1 ano, sem vida sexual ativa, procura atendimento ambulatorial com queixa de irregularidade menstrual desde a menarca, apresentando ciclos com intervalos que variam de 30 até 90 dias. Refere também aumento de pelos em face e abdome e acne persistente. Ao exame físico, IMC de 27 kg/m², presença de acne inflamatória moderada e índice de Ferriman-Gallwey igual a 9. Exames laboratoriais mostram elevação de testosterona total. Ultrassonografia pélvica evidencia útero e ovários de aspecto normal para idade.

Com base nos critérios de Rotterdam e considerando o caso clínico apresentado, qual é a interpretação mais adequada?

- A) A paciente não pode ser diagnosticada com SOP, pois preenche apenas 1 critério menor.
- B) A paciente apresenta critérios suficientes para diagnóstico de SOP.
- C) A paciente não pode ser diagnosticada com SOP, pois a menarca foi a apenas 1 ano.
- D) A paciente não pode ser diagnosticada com SOP, pois a ultrassonografia foi normal para idade.

QUESTÃO 90

Uma mulher de 47 anos, G2P2 (dois partos vaginais), comparece à consulta ginecológica queixando-se de aumento do fluxo menstrual e episódios de irregularidade nos últimos 6 meses. O exame físico revela útero discretamente aumentado de volume, indolor e móvel. A ultrassonografia transvaginal demonstra a presença de um nódulo sólido, hipoeoico, com 4,5 cm no maior eixo, localizado na parede anterior, ocupando mais de 50% da espessura miometrial, mas sem atingir a serosa nem distorcer a cavidade endometrial (Classificação FIGO 5). O endométrio possui aspecto normal e a citologia oncótica cervical está normal. A paciente não deseja novas gestações e solicita encaminhamento para cirurgia.

Qual a conduta imediata mais adequada para este caso?

- A) Indicar de histerectomia total abdominal, visto que a paciente já possui prole constituída e apresenta sintomas hemorrágicos com útero aumentado.
- B) Realizar de miomectomia por via laparoscópica, visando a preservação do órgão e controle dos sintomas, devido à localização intramural do nódulo (FIGO 5).
- C) Manter manejo clínico com expectativa e uso de sintomáticos, considerando a sintomatologia leve e a proximidade da menopausa.
- D) Encaminhar para embolização das artérias uterinas (EAU), por ser o tratamento de escolha para miomas intramurais sintomáticos em mulheres acima de 45 anos.

QUESTÃO 91

Uma mulher de 48 anos, empresária, procura atendimento médico com queixas de fogachos intensos, calores noturnos que prejudicam o sono (insônia secundária), irritabilidade e diminuição da libido. No histórico obstétrico, é G2P2A0. Relata ter sido submetida a uma histerectomia total com preservação de anexos há 10 anos, devido a uma miomatose uterina sintomática. O exame físico revela IMC de 23 kg/m², pressão arterial de 120/80 mmHg e ausência de nódulos mamários à palpação. Não apresenta antecedentes pessoais ou familiares de câncer de mama ou eventos tromboembólicos. A paciente deseja TH, mas apresenta-se preocupada com os riscos associados.

Qual a conduta mais adequada para o início da terapia hormonal nesta paciente?

- A) Prescrever Terapia Hormonal com testosterona transdérmica, visando o melhor controle dos sintomas vasomotores e da libido.
- B) Iniciar Estrogenioterapia isolada por via oral ou transdérmica, uma vez que a paciente é histerectomizada.
- C) Indicar o uso isolado de Progestagênio, Acetato de Medroxiprogesterona intramuscular ou implante subcutâneo de etonogestrel, pois possuem menos efeitos adversos.
- D) Recomendar apenas Estriol intravaginal, pois o tratamento local é suficiente para os sintomas descritos e apresenta menores riscos associados.

QUESTÃO 92

O rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil e no mundo passa por uma transição tecnológica com a substituição progressiva da citologia oncótica pelos testes de biologia molecular (DNA-HPV). Essa mudança fundamenta-se nas propriedades diagnósticas e no impacto desses testes na história natural da doença.

Considerando as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) qual a principal vantagem do rastreio primário com DNA-HPV?

- A) Especificidade superior à da citologia, o que reduz drasticamente a necessidade de colposcopias desnecessárias em mulheres jovens (abaixo de 25 anos).
- B) O alto valor preditivo negativo do teste permite que o intervalo entre os exames de rastreio seja ampliado com segurança para 5 anos.
- C) Dispensa a necessidade de triagem citológica posterior, uma vez que qualquer resultado positivo para HPV de alto risco indica diretamente a realização de colposcopia.
- D) Por ser um teste automatizado e de alta sensibilidade, o DNA-HPV elimina a influência da vacinação contra o HPV nos protocolos de rastreamento.

QUESTÃO 93

Uma paciente de 26 anos comparece à consulta ginecológica relatando corrimento vaginal abundante, de odor fétido, que se intensificou após o último período menstrual. Refere parceiro sexual único e início da vida sexual há 8 meses, utilizando anticoncepcional oral combinado como método de planejamento familiar. Ao exame especular observa-se conteúdo vaginal fluido, amarelo-esverdeado e bolhoso e colo com múltiplas petéquias. O teste do pH vaginal é de 5,5 e o teste das aminas (Whiff test) é positivo.

Diante da principal hipótese diagnóstica, qual é a conduta mais adequada para este caso?

- A) Prescrever Metronidazol 2g, via oral, em dose única para a paciente e orientar o tratamento do parceiro apenas se este apresentar sintomas uretrais evidentes.
- B) Prescrever Metronidazol 500mg, via oral, de 12 em 12 horas por 7 dias para a paciente e tratar obrigatoriamente o parceiro sexual com o mesmo esquema ou dose única.
- C) Indicar o uso de Metronidazol em creme vaginal por 10 dias, sem necessidade de tratar o parceiro.
- D) Realizar o tratamento do casal com dose única de Tinidazol 2g e Metronidazol em creme vaginal por 10 dias.

QUESTÃO 94

Uma mulher de 21 anos, com início de vida sexual há 2 anos, procura atendimento de urgência com queixa de dor abdominal baixa intensa há 4 dias, febre (38,8°C), náuseas e piora progressiva do quadro. Refere corrimento vaginal recente que iniciou após a última menstruação. Ao exame físico, apresenta dor à palpação de hipogástrio e fossas ilíacas, além de dor à mobilização do colo uterino durante o toque vaginal. Ao exame especular, observa-se secreção purulenta. Exames laboratoriais mostram leucocitose e elevação de PCR. Ultrassonografia transvaginal evidencia massa anexial complexa com conteúdo heterogêneo e septações, medindo 5,5 cm no maior eixo.

Diante da principal hipótese diagnóstica, qual é a conduta mais adequada?

- A) Prescrever anti-inflamatórios e analgésicos, com orientação de abstinência sexual até melhora dos sintomas, sem necessidade de internação ou tratamento do parceiro.
- B) Iniciar antibioticoterapia oral ambulatorial e reavaliar em 72 horas, sem necessidade de internação ou tratamento do parceiro.
- C) Internar a paciente para antibioticoterapia venosa de amplo espectro, com cobertura para germes anaeróbios, e indicar tratamento do parceiro sexual.
- D) Indicar abordagem cirúrgica imediata com laparotomia e salpingo-ooforectomia, seguida de antibioticoterapia, e indicar tratamento do parceiro sexual.

QUESTÃO 95

Uma mulher de 37 anos, sem comorbidades, comparece à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. Nega sintomas mamários e não possui antecedentes familiares de câncer de mama. Questiona sobre a melhor forma de realizar o rastreamento para câncer de mama.

Com base nas recomendações atuais de rastreamento populacional, qual é a orientação mais adequada para esta paciente?

- A) Realizar mamografia anual até completar 70 anos.
- B) Realizar mamografia bienal entre 50 e 69 anos.
- C) Realizar exame clínico das mamas até 49 anos seguido de mamografia anual até 70 anos.
- D) Realizar ultrassonografia mamária anual até 49 anos seguida de mamografia bienal entre 50 e 69 anos.

QUESTÃO 96

Uma paciente de 21 anos, Gesta 1 Para 1 (parto vaginal há 6 meses), comparece à consulta na Unidade Básica de Saúde manifestando o desejo de realizar contracepção cirúrgica definitiva (laqueadura tubária). Ela afirma não desejar novas gestações e refere que o uso de métodos reversíveis não lhe traz segurança emocional. Informa que não tem parceiro fixo e reside e depende financeiramente da mãe.

Com base na Lei nº 14.443/2022 e nas recomendações do Ministério da Saúde, qual a conduta adequada para este caso?

- A) O procedimento não pode ser realizado, uma vez que a legislação brasileira exige idade mínima de 25 anos para mulheres com menos de dois filhos vivos.
- B) O procedimento é contraindicado por se tratar de paciente jovem, com apenas 1 filho e sem parceiro fixo.
- C) A cirurgia está condicionada à autorização expressa da mãe, visto que a paciente depende financeiramente dela.
- D) A laqueadura pode ser realizada, sendo necessário aguardar o prazo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.

QUESTÃO 97

Uma paciente de 38 anos, G3P3 (partos vaginais), comparece à consulta ginecológica buscando contracepção de alta eficácia. Ao exame e anamnese, apresenta: IMC de 34 kg/m² (Obesidade Grau I), hipertensão arterial sistêmica controlada com enalapril (130x85 mmHg) e Diabetes Mellitus tipo 2 diagnosticado há 22 anos, com sinais de nefropatia diabética em estágio inicial. A paciente nega tabagismo. Refere fluxo menstrual moderado a forte.

Considerando os Critérios Médicos de Elegibilidade da Organização Mundial da Saúde (OMS) e as melhores evidências científicas, qual a conduta mais adequada?

- A) Prescrever o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG)
- B) Iniciar anticoncepcional combinado oral de baixa dosagem
- C) Indicar o uso de anticoncepcional injetável trimestral de acetato de medroxiprogesterona
- D) Recomendar o dispositivo intrauterino de cobre (DIU TCu 380A)

QUESTÃO 98

Uma mulher de 28 anos comparece à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. Durante a anamnese, a médica assistente nota equimoses em diferentes estágios de evolução nos braços e tronco, além de um comportamento esquivo e hipervigilante da paciente. Ao ser questionada em ambiente privativo, ela confirma sofrer agressões físicas recorrentes do parceiro, mas solicita expressamente que a polícia não seja acionada, pois ele é uma boa pessoa e só a agride quando está embriagado.

Diante das diretrizes atuais do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina sobre o fluxo de notificação e atendimento, qual a conduta correta?

- A) Realizar a notificação compulsória em formulário específico (VIVA/SINAN) em até 24 horas, informando obrigatoriamente às autoridades policiais e ao Ministério Público sobre o ocorrido, mesmo contra a vontade da paciente.
- B) Respeitar a autonomia da paciente e não realizar a notificação epidemiológica no SINAN, visto que o sigilo médico é absoluto em casos de violência doméstica contra adultos com capacidade civil plena, salvo se houver risco de morte iminente.
- C) Efetuar a notificação compulsória para fins epidemiológicos (VIVA/SINAN), que deve ser preenchida pelo profissional de saúde que prestou o atendimento, sem a necessidade de comunicação policial imediata, respeitando o sigilo e a autonomia da mulher.
- D) Encaminhar a paciente obrigatoriamente para a Delegacia da Mulher para que o escrivão realize a notificação no sistema de saúde, uma vez que a notificação de violência doméstica é um ato administrativo-policial e não uma atribuição do médico assistente.

QUESTÃO 99

Uma adolescente de 15 anos comparece à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. Durante a anamnese, em um momento a sós com o médico, ela revela ter iniciado a vida sexual há dois meses com um parceiro fixo e deseja iniciar contracepção com implante subdérmico, pois leu que tem alta eficácia. Ela solicita expressamente que o médico não informe sua mãe sobre esse fato, pois teme represálias familiares. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, com desenvolvimento puberal completo e exame ginecológico sem alterações.

De acordo com o Código de Ética Médica e as diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil, qual deve ser a conduta do médico em relação ao sigilo e à assistência?

- A) O sigilo deve ser mantido, pois a adolescente demonstra capacidade de discernimento e a revelação sem seu consentimento rompe a relação de confiança.
- B) O médico deve informar a mãe, obrigatoriamente, por tratar-se de uma menor de idade, mas pode manter o sigilo sobre o método contraceptivo prescrito.
- C) O médico deve quebrar o sigilo visto que a prescrição de implantes subdérmicos em menores de idade exige autorização expressa de um responsável.
- D) O médico deve convencer a adolescente a trazer a mãe para a consulta, pois o atendimento ginecológico de menores de 16 anos sem o acompanhante legal configura infração ética.

QUESTÃO 100

Uma gestante de 15 anos, primigesta, comparece à Unidade Básica de Saúde para sua primeira consulta de pré-natal. A gestação foi confirmada por teste de farmácia e a data da última menstruação indica 6 semanas de idade gestacional. Ela refere estar bem, não apresenta comorbidades prévias. Ao exame físico: PA 110x70 mmHg, IMC 21 kg/m² e desenvolvimento puberal compatível com a idade.

Com base no Protocolo de Pré-Natal de Baixo Risco do Ministério da Saúde, qual a conduta adequada quanto ao acompanhamento e parto desta paciente?

- A)** A paciente deve ser encaminhada imediatamente ao Pré-Natal de Alto Risco (PNAR), visto que a gestação na adolescência (menor de 16 anos) é classificada como fator de risco, mas o parto poderá ser acompanhado em serviço de baixa complexidade.
- B)** A gestante deve ser encaminhada para o serviço especializado de forma compartilhada, mantendo consultas na UBS bimensalmente e o parto deverá ser acompanhado em serviço de alta complexidade, independentemente da existência de complicações gestacionais.
- C)** O encaminhamento ao Pré-Natal de Alto Risco só será necessário se a adolescente apresentar complicações gestacionais, mas o parto deverá ser obrigatoriamente acompanhado em serviço de alta complexidade.
- D)** O acompanhamento deve ser mantido na Unidade Básica de Saúde e o parto poderá ser acompanhado em serviço de baixa complexidade, pois a idade isolada não é critério de alto risco para encaminhamento se a gestante não apresentar outras intercorrências clínicas.